



# Prüfungsfragen-Sammlung

300 Multiple-Choice-Fragen aus 15 Fachbereichen – zum Selbsttest mit Lösungsschlüssel und verständlichen Erklärungen im Anhang.

**Bestehen ist planbar.**

Multiple Choice

Erklärungen

3 Schwierigkeitsstufen

Lösungsschlüssel

**300**

Fragen

**15**

Fachbereiche

**A4**

druckfertig

## INHALT

- |                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1</b> Generalistische Ausbildung & Recht | <b>2</b> Pflegeprozess & Pflegeplanung |
| <b>3</b> Prävention & Gesundheitsförderung  | <b>4</b> Mobilität & Bewegung          |
| <b>5</b> Notfall & Akutsituationen          | <b>6</b> Innere Medizin                |
| <b>7</b> Chirurgie                          | <b>8</b> Pädiatrie                     |
| <b>9</b> Gynäkologie & Geburtshilfe         | <b>10</b> ... und 6 weitere Bereiche   |

△ Lernhilfe zur Prüfungsvorbereitung. Inhalte nach bestem Wissen erstellt – maßgeblich sind deine Lehrinhalte, aktuelle Leitlinien und die Standards deiner Einrichtung.

# So nutzt du die Sammlung

Erst alle Fragen eines Bereichs beantworten, dann im Lösungsteil kontrollieren. Falsche Antworten markieren und nach ein paar Tagen wiederholen.

## SCHWIERIGKEIT

• leicht • ●● mittel • ●●● schwer

## EHRLICH TESTEN

Lösungen stehen gesammelt am Ende – kein Spoiler beim Lernen.

## FACHBEREICHE

01 Generalistische Ausbildung & Recht · 20 Fragen

02 Pflegeprozess & Pflegeplanung · 20 Fragen

03 Prävention & Gesundheitsförderung · 20 Fragen

04 Mobilität & Bewegung · 20 Fragen

05 Notfall & Akutsituationen · 20 Fragen

06 Innere Medizin · 20 Fragen

07 Chirurgie · 20 Fragen

08 Pädiatrie · 20 Fragen

09 Gynäkologie & Geburtshilfe · 20 Fragen

10 Psychiatrie · 20 Fragen

11 Psychologie & Kommunikation · 20 Fragen

12 Altenpflege & Geriatrie · 20 Fragen

13 Palliativpflege · 20 Fragen

14 Rehabilitation · 20 Fragen

15 Anerkennung & Berufszulassung · 20 Fragen

# 1 Generalistische Ausbildung & Recht

20 Fragen

## 1 Wer ist in der generalistischen Ausbildung der „Träger der praktischen Ausbildung“?

● ●

- ☐ A Die Berufsgenossenschaft als zuständiger Träger der gesetzlichen Unfallversicherung
- ☐ B Das jeweilige Schulministerium des Bundeslandes als oberste zuständige Behörde
- ☐ C Die Einrichtung, die den Ausbildungsvertrag schließt und die praktische Ausbildung verantwortet
- ☐ D Die zuständige Krankenkasse als Kostenträger der monatlichen Ausbildungsvergütung

## 2 Wie lange dauert die generalistische Pflegeausbildung in Vollzeit?

●

- ☐ A 3 Jahre (in Teilzeit bis zu 5 Jahre)
- ☐ B Ein Jahr in Vollzeit ohne jede Möglichkeit einer weiteren Verlängerung
- ☐ C Zehn Jahre durchgehend berufsbegleitend in dauerhafter Teilzeitform
- ☐ D Sechs Monate als stark verkürzte und komprimierte Intensivausbildung

## 3 Was sind „vorbehaltene Tätigkeiten“ nach dem Pflegeberufgesetz?

● ● ●

- ☐ A Tätigkeiten, die nur ausgebildeten Pflegefachpersonen vorbehalten sind (z. B. Erhebung und Steuerung des Pflegeprozesses)
- ☐ B Bestimmte organisatorische Aufgaben im Bereich der Stationsverwaltung und Ablaufplanung
- ☐ C Reine hauswirtschaftliche und Reinigungstätigkeiten im Umfeld der Pflegeeinrichtung
- ☐ D Alltägliche Aufgaben, die grundsätzlich jede beliebige Person ohne Ausbildung übernehmen darf

## 4 Welche Versorgungsbereiche decken die Pflichteinsätze der generalistischen Ausbildung ab?

● ●

- ☐ A Stationäre Akutpflege, stationäre Langzeitpflege und ambulante Pflege
- ☐ B Ausschließlich die Versorgung von Patienten auf der Intensivstation
- ☐ C Ausschließlich verwaltende und organisatorische Tätigkeiten der Einrichtung
- ☐ D Ausschließlich die Assistenz bei Operationen im OP-Bereich

## 5 Was prüft die 3. Praxisbegleitung?

● ●

- ☐ A Die Grundlagen der Anästhesie und Narkoseführung
- ☐ B CE 09-11: komplexe Pflegesituationen und Koordination
- ☐ C Ausschließlich die Bedienung medizinischer Geräte
- ☐ D Nur einfache Tätigkeiten der pflegerischen Grundpflege

## 6 Was ist Kinästhetik-Grundprinzip?

● ●

- ☐ A Nur von Physiotherapeuten anwendbar
- ☐ B Natürliche Bewegungsmuster nutzen
- ☐ C Schnelle Pflege ohne Hilfsmittel
- ☐ D Vollständige Übernahme

**7 Womit beginnt der Pflegeprozess?**

● ●

- |                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Mit der abschließenden Bewertung und Evaluation der erbrachten Pflege  | <input type="radio"/> B Mit der Vorbereitung und Durchführung der Entlassung des Patienten     |
| <input type="radio"/> C Mit der Abrechnung der erbrachten Pflegeleistungen gegenüber der Kasse | <input type="radio"/> D Mit der Informationssammlung (Assessment / Erhebung des Pflegebedarfs) |

**8 Was prüft die 1. Praxisbegleitung?**

● ●

- |                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Abschlussprüfung      | <input type="radio"/> B Anästhesievorbereitung |
| <input type="radio"/> C CE 01/02/03: Einstieg | <input type="radio"/> D ECMO-Bedienung         |

**9 Was ist Evaluation im Pflegeprozess?**

● ●

- |                                                |                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Pflegediagnose stellen | <input type="radio"/> B Durchführung der Maßnahmen |
| <input type="radio"/> C Aufnahme des Patienten | <input type="radio"/> D Überprüfung ob Pflegeziele |

**10 Wie viele Stunden umfasst die generalistische Pflegeausbildung insgesamt etwa?**

● ●

- |                                                                             |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Rund 500 Stunden, aufgeteilt auf Theorie und Praxis | <input type="radio"/> B Rund 4600 Stunden (etwa 2100 Theorie + 2500 Praxis)      |
| <input type="radio"/> C Rund 100 Stunden im Rahmen eines kurzen Grundkurses | <input type="radio"/> D Deutlich über 20.000 Stunden über die gesamte Ausbildung |

**11 Was ermöglicht die Zwischenprüfung nach etwa zwei Dritteln der Ausbildung?**

● ● ●

- |                                                                                        |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Den sofortigen und vollwertigen Abschluss der Berufsausbildung | <input type="radio"/> B Den Wechsel in ein Hochschulstudium ganz ohne weitere Prüfung                                        |
| <input type="radio"/> C Sie ermöglicht nichts Besonderes und ist ohne Bedeutung        | <input type="radio"/> D Eine Standortbestimmung; in einigen Ländern kann darauf ein Pflegefachassistenten-Abschluss aufbauen |

**12 Wie viele Stunden umfasst der Vertiefungseinsatz?**

● ●

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <input type="radio"/> A 800h | <input type="radio"/> B 500h |
| <input type="radio"/> C 120h | <input type="radio"/> D 280h |

**13 Welche schulische Zugangsvoraussetzung gilt üblicherweise für die generalistische Pflegeausbildung?**

● ●

- |                                                                                                          |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Ausschließlich das Abitur oder eine gleichwertige allgemeine Hochschulreife      | <input type="radio"/> B Ein mittlerer Schulabschluss oder ein Hauptschulabschluss mit abgeschlossener Ausbildung bzw. Pflegeassistenten |
| <input type="radio"/> C Gar kein bestimmter Schulabschluss, da der Zugang zur Ausbildung völlig frei ist | <input type="radio"/> D Ein bereits erfolgreich abgeschlossenes Studium in einem medizinischen Fachbereich                              |

**14 Was regelt das PfIBG?**

●

- ☐ A Generalistische Ausbildung
- ☐ B Die Ausbildung zur Krankenpflege
- ☐ C Die Ausbildung zur Altenpflege
- ☐ D ATA/OTA-Ausbildung

**15 Worum geht es im Pflegemodell von Dorothea Orem?**

● ● ●

- ☐ A Um die Ernährung allein
- ☐ B Um die Technik der Blutabnahme
- ☐ C Um die Selbstpflege und den Ausgleich von Selbstpflegedefiziten
- ☐ D Um die Krankenhausfinanzierung

**16 Was ist die NANDA-Pflegediagnose?**

● ● ●

- ☐ A Eine ärztliche Diagnose zur Feststellung einer Erkrankung
- ☐ B Ein System, das ausschließlich in den USA angewendet wird
- ☐ C Internationales Klassifikationssystem für Pflegediagnosen
- ☐ D Ein längst veraltetes und nicht mehr gebräuchliches System

**17 Was sind CE 01-11 in der GPA?**

● ●

- ☐ A Einzelne schriftliche und mündliche Prüfungen im Verlauf der Ausbildung
- ☐ B Die verschiedenen praktischen Einsätze in Klinik und ambulanter Pflege
- ☐ C Erworbene Zusatzzertifikate für einzelne Fachbereiche der Pflege
- ☐ D Curriculare Einheiten = Lernbereiche der generalistischen Pflegeausbildung

**18 Seit wann ist die generalistische Pflegeausbildung in Kraft?**

●

- ☐ A 01.01.2020
- ☐ B 01.09.2021
- ☐ C 01.01.2022
- ☐ D 01.01.2018

**19 Was ist der Pädiatrie-Pflichteinsatz in der GPA?**

● ●

- ☐ A Ein rein optionaler Einsatz ohne festgelegte Mindeststundenzahl
- ☐ B Ein Pflichteinsatz im Umfang von insgesamt 300 Stunden
- ☐ C Ein Wahlpflichteinsatz von 500 Stunden am Ende der Ausbildung
- ☐ D Pflicht: 120h Kinder- und Jugendmedizin

**20 Welche CE behandelt Akutsituationen?**

● ●

- ☐ A CE 05
- ☐ B CE 09
- ☐ C CE 03
- ☐ D CE 06

## 2 Pflegeprozess & Pflegeplanung

20 Fragen

### 21 Was sind die 4 Hauptbestandteile einer Pflegeplanung?

- ☐ A Pflegeproblem/Pflegediagnose, Pflegeziel
- ☐ B Problem, Diagnose, Therapie, Entlassung
- ☐ C Anamnese, Befund, Plan, Kontrolle
- ☐ D Aufnahme, Behandlung, Pflege, Entlassung

### 22 Was ist Dekubitus-Kategorie II?

- ☐ A Muskel/Knochen sichtbar
- ☐ B Blasenbildung oder Erosion
- ☐ C Vollhautverlust bis Subkutis
- ☐ D Nicht-wegdrückbare Rötung

### 23 Was sind Ressourcen in der Pflegeplanung?

- ☐ A Bestehende Pflegeprobleme und Defizite
- ☐ B Vorhandene Fähigkeiten und Stärken
- ☐ C Verfügbares Pflegematerial und Hilfsmittel
- ☐ D Die ärztlichen Diagnosen des Patienten

### 24 Was ist der Pflegebericht?

- ☐ A Reine Verlaufskurve der Vitalzeichen
- ☐ B Täglicher Bericht der ärztlichen Visite
- ☐ C Dokumentation von Pflegeverlauf und Reaktionen
- ☐ D Dokumentation nur der Medikamentengabe

### 25 Wie formuliert man konkrete Pflegemaßnahmen?

- ☐ A Konkret: WER, WAS, WANN/WIE OFT
- ☐ B Nur die Medikamentengabe notieren
- ☐ C Allgemein: Patient pflegen
- ☐ D Übernahme der ärztlichen Anordnungen

### 26 Was ist ein (hausinterner) Pflegestandard?

- ☐ A Ein gesetzlich verankertes Verbot bestimmter Pflegehandlungen
- ☐ B Ein verbindlicher Dienstplan für den Ablauf der Schicht
- ☐ C Eine unverbindliche Idee ohne festgelegte Vorgaben zur Durchführung
- ☐ D Eine verbindliche Vorgabe, wie eine bestimmte Pflegemaßnahme fachgerecht durchzuführen ist

### 27 Was gilt bei Clostridium-difficile-Infektion bezüglich Händehygiene?

- ☐ A Keine besondere Hygiene nötig
- ☐ B Händewaschen statt Alkohol-Desinfektion
- ☐ C Es genügen Einmalhandschuhe
- ☐ D Händedesinfektion mit Alkohol wie normal

### 28 Wann sollten Einmalhandschuhe NICHT getragen werden?

- ☐ A Bei Wundversorgung
- ☐ B Beim normalen Patientenkontakt
- ☐ C Bei Katheteranlage
- ☐ D Bei Blutentnahme

**29 Was ist Pflegeüberleitung?**

● ●

- |                                                    |                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Fortbildung                | <input type="radio"/> B Eine Pflegediagnose      |
| <input type="radio"/> C Übergabe innerhalb Station | <input type="radio"/> D Strukturierte Weitergabe |

**30 Was sind die 5 Momente der WHO-Händehygiene?**

● ●

- |                                                                                                                                           |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Vor Patientenkontakt · Vor aseptischer Tätigkeit · Nach Körperflüssigkeit · Nach Patientenkontakt · Nach Umgebung | <input type="radio"/> B Beim Betreten · Beim Verlassen · Beim Verbandswechsel  |
| <input type="radio"/> C Morgens · Mittags · Abends · Nach Blut · Nach WC                                                                  | <input type="radio"/> D Vor/nach der Pause · Nach der Toilette · Vor dem Essen |

**31 Was ist Pflegevisite?**

● ●

- |                                                                        |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Kontrollrundgang nur durch die Stationsleitung | <input type="radio"/> B Systematische Überprüfung des Pflegeprozesses |
| <input type="radio"/> C Anleitung der Auszubildenden am Patientenbett  | <input type="radio"/> D Ärztliche Visite ohne Pflegebeteiligung       |

**32 Was ist die NRS und wie wird sie eingesetzt?**

●

- |                                                  |                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Nationales Sturzregister | <input type="radio"/> B Reanimationsschema         |
| <input type="radio"/> C Numerische Rating-Skala  | <input type="radio"/> D Nutritional Risk Screening |

**33 Was ist der Unterschied Pflegediagnose vs. ärztliche Diagnose?**

● ●

- |                                                              |                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Beide beschreiben dieselbe Krankheit | <input type="radio"/> B Pflegediagnose weniger wichtig |
| <input type="radio"/> C Ärztlich = Krankheit/Pathologie      | <input type="radio"/> D Ärztlich ist detaillierter     |

**34 Was sind potenzielle Pflegeprobleme?**

● ●

- |                                                                               |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Medikamentennebenwirkungen                            | <input type="radio"/> B Ärztliche Diagnosen           |
| <input type="radio"/> C Risiken/Gefährdungen, die noch nicht eingetreten sind | <input type="radio"/> D Bereits eingetretene Probleme |

**35 Welche Handschuhe werden bei sterilen Eingriffen verwendet?**

● ●

- |                                                         |                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Haushaltshandschuhe             | <input type="radio"/> B Sterile OP-Handschuhe (Non-Touch-Anlegetechnik) |
| <input type="radio"/> C Normale Untersuchungshandschuhe | <input type="radio"/> D Latexfreie Handschuhe nur bei Allergie          |

**36 Welche Wäsche kommt in den roten Sack?**

●

- |                                                                          |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Gebrauchte Abdecktücher aus dem Operationssaal   | <input type="radio"/> B Ganz normale, nur leicht verschmutzte Bettwäsche           |
| <input type="radio"/> C Grundsätzlich die gesamte Wäsche aller Patienten | <input type="radio"/> D Infektionswäsche – direkt verschlossen im Zimmer entsorgen |

**37**
**Was ist bei der Isolierung eines MRSA-Patienten zu beachten?**

● ● ●

- ☐ **A** Der Patient darf grundsätzlich gar nicht besucht werden
- ☐ **B** Einzelzimmer, Schutzkittel, Handschuhe und FFP2 bei engem Kontakt
- ☐ **C** Es genügt das alleinige Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
- ☐ **D** Es genügt das alleinige Tragen von Einmalhandschuhen

**38**
**Was muss bei der Formulierung eines Pflegeproblems enthalten sein?**

● ●

- ☐ **A** Problem, Ziel und Maßnahme gemeinsam
- ☐ **B** Symptome und ärztliche Verdachtsdiagnose
- ☐ **C** Problem + Ursache (Ätiologie)
- ☐ **D** Pflegeziel und geplante Maßnahme

**39**
**Was ist ein korrektes SMART-Pflegeziel?**

● ●

- ☐ **A** Mobilität verbessern
- ☐ **B** Patient geht am 3. Tag mit Hilfe 10m
- ☐ **C** Schmerzen reduzieren
- ☐ **D** Patient soll sich besser fühlen

**40**
**Was ist Virginia Hendersons Pflegemodell?**

● ● ●

- ☐ **A** 14 Grundbedürfnisse – Hilfe zur Selbstständigkeit
- ☐ **B** Ein reines Pflegeprozessmodell zur Ablaufsteuerung der Pflege
- ☐ **C** Das AEDL-Modell der aktivitätsorientierten Lebensbereiche
- ☐ **D** Das Konzept der Salutogenese zur Entstehung von Gesundheit

### 3 Prävention & Gesundheitsförderung

20 Fragen

#### 41 Wer gibt in Deutschland die offiziellen Impfeempfehlungen heraus?

- ☐ A WHO
- ☐ B STIKO am RKI
- ☐ C Hausärzterverband
- ☐ D Pflegekammer

#### 42 Was ist das Ziel der motivierenden Gesprächsführung (Motivational Interviewing)?

- ☐ A Den Patienten mit Nachdruck zu einer Entscheidung zu überreden
- ☐ B Die eigene Veränderungsmotivation des Patienten stärken
- ☐ C Dem Patienten klare Anweisungen und Vorgaben zu erteilen
- ☐ D Eine ärztliche Diagnose für den Patienten zu stellen

#### 43 Was ist ein Ziel des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)?

- ☐ A Krankenstände durch Druck senken
- ☐ B Gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen schaffen und Beschäftigte gesund halten
- ☐ C Gesetzliche Vorgaben nur minimal erfüllen
- ☐ D Ausschließlich Kosten einsparen

#### 44 Wie hebt man beim Anheben von Lasten rückschonend?

- ☐ A Mit rundem Rücken und gestreckten Beinen
- ☐ B Ruckartig und möglichst schnell
- ☐ C Aus den Beinen heben, Rücken gerade, Last nah am Körper
- ☐ D Grundsätzlich allein und ohne Hilfsmittel

#### 45 Womit prüft man, ob eine Hautrötung ein Dekubitus Kategorie 1 sein könnte?

- ☐ A Mit dem Thermometer
- ☐ B Mit dem Blutdruckmessgerät
- ☐ C Mit einer Blutentnahme
- ☐ D Mit dem Fingertest (Wegdrückbarkeit prüfen)

#### 46 Was ist ein Kernziel der Patientenedukation?

- ☐ A Abhängigkeit erhöhen
- ☐ B Informationen zurückhalten
- ☐ C Gesundheitskompetenz und Selbstmanagement stärken
- ☐ D Reine Medikamentenverteilung

#### 47 Welche Aufgabe hat das Robert Koch-Institut (RKI)?

- ☐ A Infektionskrankheiten überwachen und Präventionsempfehlungen erarbeiten
- ☐ B Die Zulassung und Prüfung neuer Arzneimittel und Impfstoffe
- ☐ C Die Ausbildung und Prüfung von Pflegekräften im Land
- ☐ D Die Festlegung der Höhe der Beiträge zur Krankenversicherung

**48 Wie lange sollte die hygienische Händedesinfektion üblicherweise einwirken?** ●●

- ☐ A Mindestens 30 Sekunden
- ☐ B Etwa 3 Sekunden
- ☐ C Genau 5 Minuten
- ☐ D Die Zeit spielt keine Rolle

**49 Welche Maßnahme ist am wirksamsten gegen nosokomiale Infektionen?** ●

- ☐ A Hygienische Händedesinfektion
- ☐ B Antibiotika-Prophylaxe bei allen Patienten
- ☐ C Tägliches Wischen der Fußböden
- ☐ D Mundschutz für Besucher

**50 Was beschreibt das Konzept der Salutogenese (Antonovsky)?** ●●

- ☐ A Entstehung und Erhalt von Gesundheit
- ☐ B Entstehung von Krankheit
- ☐ C Reine Risikovermeidung
- ☐ D Genetische Vererbung

**51 Was ist ein typisches Beispiel für Sekundärprävention?** ●

- ☐ A Schutzimpfung
- ☐ B Rehabilitation nach Schlaganfall
- ☐ C Gesunde Ernährung
- ☐ D Krebsfrüherkennungsuntersuchung

**52 Welche Pflegemaßnahme dient der Soor- und Parotitisprophylaxe?** ●●

- ☐ A Den Patienten nüchtern lassen
- ☐ B Vorsorgliche Antibiotika-Gabe
- ☐ C Sauerstoffgabe über die Nase
- ☐ D Regelmäßige Mund- und Zahnpflege sowie Speichelanregung

**53 Welche Maßnahme zählt zur physikalischen Thromboseprophylaxe?** ●●

- ☐ A Die strikte Einhaltung durchgehender und dauerhafter Bettruhe
- ☐ B Frühmobilisation und medizinische Thromboseprophylaxestrümpfe
- ☐ C Eine möglichst tiefe Lagerung beider Beine des Patienten
- ☐ D Das Trinken großer Mengen von koffeinhaltigem Kaffee

**54 Welche Schutzausrüstung schützt am ehesten vor einer Tröpfcheninfektion?** ●●

- ☐ A Ein Mund-Nasen-Schutz bzw. eine Atemschutzmaske
- ☐ B Sterile Einmalhandschuhe für den direkten Patientenkontakt
- ☐ C Eine Kopfhaut zur Abdeckung von Haaren und Kopfhaut
- ☐ D Überschuhe zum Schutz vor Verunreinigung des Bodens

**55 Welcher Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist beeinflussbar (modifizierbar)?** ●

- ☐ A Das Lebensalter
- ☐ B Rauchen und Bewegungsmangel
- ☐ C Die genetische Veranlagung
- ☐ D Das Geschlecht

**56 Was versteht man unter Quartärprävention?**

● ● ●

- |                                                                                                     |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Die Schutzimpfung von Neugeborenen gegen Infektionen                        | <input type="radio"/> B Ein Früherkennungs-Screening zur Entdeckung von Krebs |
| <input type="radio"/> C Vermeidung unnötiger oder übermäßiger medizinischer Maßnahmen (Übersorgung) | <input type="radio"/> D Die Erste Hilfe am Ort eines eingetretenen Unfalls    |

**57 Wie viele „Momente der Händedesinfektion“ definiert die WHO?**

●

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <input type="radio"/> A Zwei | <input type="radio"/> B Drei |
| <input type="radio"/> C Fünf | <input type="radio"/> D Zehn |

**58 Welche Impfung wird für Pflegepersonal arbeitsmedizinisch besonders empfohlen?**

● ●

- |                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Gelbfieber    | <input type="radio"/> B Tollwut     |
| <input type="radio"/> C FSME für alle | <input type="radio"/> D Hepatitis B |

**59 Welche Maßnahme senkt das Aspirationsrisiko bei der Nahrungsaufnahme?**

● ●

- |                                                         |                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Den Patienten im Liegen füttern | <input type="radio"/> B Aufrechte Sitzposition und angepasste Kostkonsistenz |
| <input type="radio"/> C Große Bissen schnell anreichen  | <input type="radio"/> D Während des Schluckens ablenken                      |

**60 Was bedeutet Empowerment in der Gesundheitsförderung?**

●

- |                                                                                                      |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Die wohlmeinende Bevormundung und Entscheidungsübernahme für den Patienten   | <input type="radio"/> B Die reine Weitergabe von Informationen ohne aktive Beteiligung des Patienten |
| <input type="radio"/> C Befähigung zu mehr Selbstbestimmung und Kontrolle über die eigene Gesundheit | <input type="radio"/> D Die gezielte Gabe von Medikamenten zur Verbesserung der Gesundheit           |

## 4 Mobilität & Bewegung

20 Fragen

### 61 Wodurch unterscheidet sich ein Rollator von einem Gehbock?

● ●

- |                                                                                                             |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Der Rollator hat Räder für flüssiges Gehen, der Gehbock wird angehoben und versetzt | <input type="radio"/> B Beide Gehhilfen sind vollständig identisch und gleich zu bedienen |
| <input type="radio"/> C Der Gehbock verfügt zusätzlich über einen elektrischen Antrieb                      | <input type="radio"/> D Der Rollator ist ausschließlich für Kinder gedacht und gebaut     |

### 62 Was ist das wichtigste Prinzip der Kontrakturenprophylaxe?

● ●

- |                                               |                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Strikte Bettruhe      | <input type="radio"/> B Hochlagerung aller Gelenke                       |
| <input type="radio"/> C Fixierung der Gelenke | <input type="radio"/> D Regelmäßige Bewegung und physiologische Lagerung |

### 63 Welche Umgebungsmaßnahme senkt das Sturzrisiko?

●

- |                                                                              |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Lose herumliegende Teppiche und Läufer auf dem Boden | <input type="radio"/> B Eine bewusst gedämpfte, schwache Beleuchtung der Räume |
| <input type="radio"/> C Gute Beleuchtung, rutschfeste Schuhe und freie Wege  | <input type="radio"/> D Feuchte, frisch gewischte und dadurch glatte Böden     |

### 64 Was kennzeichnet einen individuellen Bewegungsförderungsplan?

● ●

- |                                                               |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Ein starres Schema für alle Patienten | <input type="radio"/> B Ausschließlich ärztliche Anordnung ohne Pflege                         |
| <input type="radio"/> C Den Verzicht auf Dokumentation        | <input type="radio"/> D An Ressourcen, Risiko und Zielen des Patienten ausgerichtete Maßnahmen |

### 65 Wie beugt man einem orthostatischen Kreislaufabfall beim Mobilisieren vor?

● ●

- |                                                                  |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Den Patienten ruckartig aufstehen lassen | <input type="radio"/> B Sofort längere Strecken gehen lassen                                                  |
| <input type="radio"/> C Flach liegend aus dem Bett ziehen        | <input type="radio"/> D Stufenweise mobilisieren: erst aufsetzen, Kreislauf adaptieren lassen, dann aufstehen |

### 66 Worauf zielt der Expertenstandard Dekubitusprophylaxe (DNQP) primär ab?

●

- |                                                                |                                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Wundversorgung bestehender Dekubitus   | <input type="radio"/> B Tägliches Wiegen |
| <input type="radio"/> C Druckentlastung und Risikoeinschätzung | <input type="radio"/> D Antibiotikagabe  |

### 67 Was kennzeichnet aktivierende Körperpflege?

●

- |                                                                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Pflegekraft übernimmt vollständig          | <input type="radio"/> B Pflege nur durch Angehörige |
| <input type="radio"/> C Ressourcen des Patienten werden einbezogen | <input type="radio"/> D Verzicht auf Körperpflege   |

**68 Was ist rückschonendes Arbeiten beim Transfer?**

- ☐ A Last körpernah, aus den Beinen heben, Rücken gerade, nicht verdrehen
- ☐ B Last weit vom Körper weg halten und den Rücken verdrehen
- ☐ C Mit gestreckten Beinen bücken
- ☐ D Ruckartig und schnell heben

**69 Welcher Faktor erhöht das Sturzrisiko?**

- ☐ A Regelmäßige Bewegung
- ☐ B Polypharmazie und Sehstörungen
- ☐ C Rutschfeste Schuhe
- ☐ D Gute Beleuchtung

**70 Für welche Patientengruppe ist das Bobath-Konzept vor allem gedacht?**

- ☐ A Frisch operierte Patienten mit einer Bauchwunde
- ☐ B Ausschließlich Neugeborene und junge Säuglinge
- ☐ C Menschen mit zentralen neurologischen Störungen, z. B. nach Schlaganfall
- ☐ D Patienten mit einer harmlosen fieberhaften Erkältung

**71 Wann ist ein Patientenlifter indiziert?**

- ☐ A Bei voll mobilen Patienten, die sich selbstständig bewegen können
- ☐ B Grundsätzlich nie, da ein Transfer immer manuell erfolgen sollte
- ☐ C Ausschließlich während der Nacht zur Entlastung des Personals
- ☐ D Bei schwer immobilen Patienten, die nicht sicher manuell transferiert werden können

**72 Welche Maßnahme gehört zur Basis-Thromboseprophylaxe?**

- ☐ A Bettruhe ohne Bewegung
- ☐ B Frühmobilisation und Bewegungsübungen
- ☐ C Flüssigkeitsrestriktion
- ☐ D Wärmflasche an den Beinen

**73 Was bewirkt die 30-Grad-Schräglage?**

- ☐ A Sie fixiert den Patienten dauerhaft in einer festen Position
- ☐ B Sie entlastet Kreuzbein und Trochanter durch Gewichtsverlagerung auf die Gesäßmuskulatur
- ☐ C Sie macht eine regelmäßige Inspektion der Haut überflüssig
- ☐ D Sie dient ausschließlich der erleichterten Nahrungsaufnahme

**74 Was ist das Ziel der Mikrolagerung (Mikrobewegung)?**

- ☐ A Den Patienten jeweils vollständig auf die andere Seite umzudrehen
- ☐ B Vor allem die Bettwäsche und die Matratze zu schonen
- ☐ C Jede Form von Bewegung möglichst vollständig zu vermeiden
- ☐ D Durch kleine Positionsveränderungen die Druckpunkte regelmäßig leicht zu verändern

**75 Was beschreibt die Virchow-Trias?**

● ● ●

- ☐ A Drei verschiedene Bereiche des Blutzuckerspiegels
- ☐ B Die drei Schweregrade eines entstehenden Dekubitus
- ☐ C Gefäßwandschaden, verlangsamter Blutfluss und erhöhte Gerinnungsneigung
- ☐ D Drei aufeinanderfolgende Stufen des Bewusstseins

**76 Welche Reihenfolge ist bei der Mobilisation sinnvoll?**

●

- ☐ A Sofort gehen, dann hinsetzen
- ☐ B Bett, dann an die Bettkante setzen, sicherer Stand, dann Gehen
- ☐ C Nur passiv im Bett belassen
- ☐ D Direkt Treppen steigen

**77 Wofür wird ein Rutsch- bzw. Transferbrett eingesetzt?**

●

- ☐ A Zur nicht-invasiven Messung des arteriellen Blutdrucks
- ☐ B Um sitzende Transfers (z. B. Bett-Rollstuhl) zu erleichtern
- ☐ C Zur Versorgung und zum Verbinden von offenen Wunden
- ☐ D Zum Anreichen von Speisen und Getränken beim Essen

**78 Welche Sicherheitsmaßnahme gehört zu jedem Rollstuhl-Transfer?**

●

- ☐ A Die Feststellbremsen bewusst offen und gelöst lassen
- ☐ B Die Fußstützen des Rollstuhls unten und ausgeklappt lassen
- ☐ C Den Transfer ohne vorherige Ansage an den Patienten beginnen
- ☐ D Bremsen feststellen und auf festes Schuhwerk achten

**79 Welche Körperstellen sind in Rückenlage besonders dekubitusgefährdet?**

●

- ☐ A Vor allem die Handflächen und die Innenseiten der Unterarme
- ☐ B Kreuzbein, Fersen und Hinterkopf
- ☐ C In erster Linie der Bauchnabel und die umgebende Bauchdecke
- ☐ D Hauptsächlich die Wangen und die seitlichen Gesichtspartien

**80 Bei welcher Erkrankung sind Kompressions- bzw. Thrombosestrümpfe mit Vorsicht anzuwenden oder kontraindiziert?**

● ● ●

- ☐ A Bei einer leichten Erkältung mit Schnupfen und Husten
- ☐ B Fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)
- ☐ C Bei völlig gesunden Beinen ohne jede Gefäßerkrankung
- ☐ D Bei anhaltenden Kopfschmerzen und Migräne des Patienten

## 5 Notfall & Akutsituationen

20 Fragen

**81** Wie ist das Verhältnis von Thoraxkompressionen zu Beatmungen bei der Erwachsenen-Reanimation (ERC 2025)? ●

☐ A 30:2

☐ B 5:1

☐ C 10:2

☐ D 15:2

**82** Wann wird die stabile Seitenlage angewendet? ●

☐ A Bei ansprechbaren und wachen Patienten mit klarem Bewusstsein

☐ B Bei einem eingetretenen Kreislaufstillstand ohne Atmung

☐ C Bei bewusstlosen Personen mit normaler (ausreichender) Atmung

☐ D Bei einem Bruch des Beins mit sichtbarer Fehlstellung

**83** Wofür steht das 'E' im ABCDE-Schema? ●●

☐ A Erhebung des Elektrolythaushalts und Beurteilung des Ernährungszustands

☐ B Elektrokardiogramm zur fortlaufenden Kontrolle des Herzrhythmus schreiben

☐ C Exposure/Environment – Entkleiden, Untersuchen, Wärmeerhalt

☐ D Erhebung der Eigen- und Fremdanamnese gemeinsam mit den Angehörigen

**84** Welches Symptom ist typisch für einen akuten Herzinfarkt? ●●

☐ A Ausschließlich ein isolierter Kopfschmerz ohne jegliche weitere Begleitsymptome

☐ B Ein örtlich eng begrenzter, wandernder Juckreiz am Unterschenkel

☐ C Anhaltender Brustschmerz/Druck, evtl. Ausstrahlung in Arm oder Kiefer, Kaltschweißigkeit

☐ D Ein grundsätzlich in jedem Fall begleitend auftretendes hohes Fieber

**85** Wie werden nicht-defibrillierbare Rhythmen (Asystolie, PEA) behandelt? ●●●

☐ A Sofortige Defibrillation mit maximaler Energie, da grundsätzlich jeder Herzstillstand schockbar ist

☐ B Zunächst nur abwarten und den Herzrhythmus über mehrere Minuten hinweg am Monitor beobachten

☐ C Hochwertige Herzdruckmassage und frühzeitig Adrenalin, keine Defibrillation

☐ D Ausschließlich Beatmung ohne begleitende Herzdruckmassage, bis der Notarzt eintrifft

**86** Was wird im ABCDE-Schema ZUERST beurteilt? ●

☐ A Exposure

☐ B Breathing

☐ C Airway

☐ D Disability

**87** Welche Nummer ist der europaweite Notruf? ●

☐ A 110

☐ B 116117

☐ C 19222

☐ D 112

**88 Wie viele Dringlichkeitsstufen hat das Manchester-Triage-System (MTS)?**

- ☐ A 5
 ☐ B 3
- ☐ C 6
 ☐ D 4

**89 Welche Kompressionsfrequenz empfiehlt der ERC 2025 bei der Reanimation?**

- ☐ A 100–120/min
 ☐ B 60–80/min
- ☐ C 80–100/min
 ☐ D 140–160/min

**90 Was ist die richtige Erstmaßnahme bei einer kleinflächigen Verbrennung?**

- ☐ A Die verbrannte Stelle sofort mit Eis oder einem Kühlakku direkt auf der Haut kühlen
 ☐ B Butter, Speiseöl oder Mehl großzügig auf die verbrannte Hautstelle auftragen
- ☐ C Mit lauwarmem Wasser kühlen, keine Hausmittel, Wunde locker keimarm bedecken
 ☐ D Entstehende Brandblasen umgehend öffnen und die abgelöste Haut vorsichtig entfernen

**91 Wofür steht das 'C' im ABCDE-Schema?**

- ☐ A Consciousness
 ☐ B Circulation
- ☐ C Control
 ☐ D Capillary

**92 Wie tief wird beim Erwachsenen thoraxkomprimiert (ERC 2025)?**

- ☐ A 5–6 cm
 ☐ B 2–3 cm
- ☐ C 3–4 cm
 ☐ D 7–8 cm

**93 Die MTS-Stufe GRÜN bedeutet ...**

- ☐ A 10 min
 ☐ B sofort
- ☐ C nicht dringend, 120 min
 ☐ D normal, 90 min

**94 Worauf ist bei der Thoraxkompression zu achten?**

- ☐ A Eine möglichst weiche und nachgebende Unterlage unter dem Brustkorb
 ☐ B Nur eine flache, oberflächliche Drucktiefe ohne vollständige Kompression
- ☐ C Harte Unterlage, vollständige Entlastung nach jeder Kompression, Unterbrechungen minimieren
 ☐ D Ein bewusst langsames und gleichmäßiges Drücken mit langen Pausen

**95 Wie beginnt die Reanimation beim Kind durch geschultes Personal (ERC 2025)?**

- ☐ A Sofort mit 30 Herzdruckmassagen beginnen, noch vor jeder Beatmung
 ☐ B Mit 5 initialen Beatmungen, dann Kompressionen zu Beatmungen im Verhältnis 15:2
- ☐ C Ausschließlich beatmen und dabei ganz auf Kompressionen verzichten
 ☐ D Im Verhältnis 30:2 vorgehen, jedoch vollständig ohne Beatmungen

**96**
**Welche Schockform entsteht durch massiven Flüssigkeits- oder Blutverlust?**

● ●

- ☐ A Kardiogener Schock
- ☐ B Septischer Schock
- ☐ C Hypovolämischer Schock
- ☐ D Anaphylaktischer Schock

**97**
**Welche Zeichen sprechen für einen hypovolämischen Schock?**

● ●

- ☐ A Blasse, kaltschweißige Haut, schneller schwacher Puls, niedriger Blutdruck
- ☐ B Warme, rosige Haut und langsamer Puls
- ☐ C Hoher Blutdruck und trockene Haut
- ☐ D Rote Wangen und Fieber

**98**
**Was tut man bei einem ansprechbaren Erwachsenen mit vollständiger Atemwegsverlegung durch einen Fremdkörper?**

● ●

- ☐ A Sofort mit der Herzdruckmassage beginnen, obwohl der Patient noch bei Bewusstsein und ansprechbar ist
- ☐ B Dem Patienten reichlich Wasser zu trinken geben, um den Fremdkörper hinunterzuspülen
- ☐ C Zunächst abwarten, ob sich der Fremdkörper von selbst durch weiteres Husten löst
- ☐ D Bis zu 5 Rückenschläge, dann bis zu 5 Oberbauchkompressionen (Heimlich) im Wechsel

**99**
**Welcher Wartezeit entspricht die MTS-Stufe ORANGE (sehr dringend)?**

● ●

- ☐ A sofort
- ☐ B 10 Minuten
- ☐ C 90 Minuten
- ☐ D 30 Minuten

**100**
**Was wird im ABCDE-Schema unter 'B' beurteilt?**

●

- ☐ A Breathing – die Atmung (Atemfrequenz, SpO<sub>2</sub>, Auskultation)
- ☐ B Der Blutzuckerspiegel und der allgemeine Stoffwechselzustand des Patienten
- ☐ C Der arterielle Blutdruck und die aktuelle Herzfrequenz
- ☐ D Der Bewusstseinszustand und die Reaktion der Pupillen auf Licht

## 6 Innere Medizin

20 Fragen

**101 Ab welchem Wert spricht man von arterieller Hypertonie?**

- ☐ A 140/90 mmHg
- ☐ B 120/80 mmHg
- ☐ C 130/80 mmHg
- ☐ D 160/100 mmHg

**102 Welcher Normbereich gilt für Bikarbonat ( $\text{HCO}_3^-$ ) im Blut?**

- ☐ A 22–26 mmol/l
- ☐ B 2–6 mmol/l
- ☐ C 40–50 mmol/l
- ☐ D 60–70 mmol/l

**103 Welche arterielle Sauerstoffsättigung ( $\text{SaO}_2/\text{SpO}_2$ ) gilt bei Lungengesunden als normal?**

- ☐ A Etwa 50–60 %
- ☐ B Etwa 70–80 %
- ☐ C Etwa 95–99 %
- ☐ D Genau 100 % erforderlich

**104 Wodurch wird eine arterielle BGA meist gewonnen?**

- ☐ A Aus einer gewöhnlichen venösen Verweilkanüle am Handrücken
- ☐ B Aus einer frisch gewonnenen Urinprobe des Patienten
- ☐ C Ausschließlich durch einen kleinen Stich in die Fingerbeere
- ☐ D Durch arterielle Punktion (z. B. A. radialis, nach Allen-Test) oder aus einem arteriellen Katheter

**105 Was ist Dysphagie nach Schlaganfall und welche Gefahr besteht?**

- ☐ A Hörstörung
- ☐ B Sehstörung
- ☐ C Schluckstörung
- ☐ D Gehstörung

**106 Was bedeutet FAST beim Schlaganfall?**

- ☐ A Fast, Accurate, Safe, Treatment
- ☐ B Focused Assessment Stroke Tool
- ☐ C First Aid Stroke Treatment
- ☐ D Face, Arms (Armlähmung), Speech

**107 Was unterscheidet Asthma bronchiale typischerweise von der COPD?**

- ☐ A Es gibt keinen Unterschied
- ☐ B Asthma ist immer irreversibel
- ☐ C Asthma ist meist anfallsartig und weitgehend reversibel
- ☐ D Asthma betrifft nur ältere Raucher

**108 Was bedeutet eine Azidose?**

- ☐ A Ein pH über 7,45
- ☐ B Ein pH unter 7,35 (Übersäuerung des Blutes)
- ☐ C Ein normaler pH
- ☐ D Ein hoher Sauerstoffwert

**109**
**Ab welchen pH-Werten wird es akut lebensbedrohlich?**

● ● ●

- ☐ A pH unter 7,0 oder über 7,8
- ☐ B Bei den Normalwerten von pH 7,35 und pH 7,45
- ☐ C Bereits bei einem leicht abweichenden pH von 7,30
- ☐ D Bereits bei einem leicht abweichenden pH von 7,50

**110**
**Wie verändert sich die BGA bei einer respiratorischen Azidose (z. B. schwere COPD, Hypoventilation)?**

● ● ●

- ☐ A pH hoch, pCO<sub>2</sub> niedrig
- ☐ B pH niedrig, HCO<sub>3</sub> stark erniedrigt
- ☐ C pH normal, alle Werte normal
- ☐ D pH niedrig, pCO<sub>2</sub> erhöht

**111**
**Was bedeutet NYHA III bei Herzinsuffizienz?**

● ●

- ☐ A Keine Symptome
- ☐ B Symptome in Ruhe
- ☐ C Symptome bei leichter Belastung
- ☐ D Symptome bei stärkerer Belastung

**112**
**Was ist die Kussmaul-Atmung?**

● ● ●

- ☐ A Eine flache, langsame und ruhige Atmung während des Schlafs
- ☐ B Ein vollständiger Stillstand der Atmung über mehrere Sekunden
- ☐ C Eine tiefe, gleichmäßig beschleunigte Atmung als Kompensation der metabolischen Azidose
- ☐ D Eine feuchte, rasselnde Atmung wie beim Lungenödem

**113**
**Was ist das Bobath-Konzept in der Schlaganfallpflege?**

● ●

- ☐ A Dekubitusprophylaxe-Konzept
- ☐ B Medikamentöse Therapie
- ☐ C Kommunikationshilfe
- ☐ D Rehabilitationskonzept: betroffene

**114**
**Welches Symptom weist auf ein Lungenödem hin?**

● ● ●

- ☐ A Eine trockene, unauffällige Haut ganz ohne begleitende Beschwerden
- ☐ B Anhaltende, krampfartige Schmerzen im Bereich des Bauchraums
- ☐ C Eine sichtbare Schwellung im Bereich der großen Gelenke
- ☐ D Schwere Atemnot mit brodelnden Rasselgeräuschen, ggf. schaumiger Auswurf

**115**
**Warum darf bei COPD NICHT unkontrolliert hochdosiert O<sub>2</sub> gegeben werden?**

● ● ●

- ☐ A O<sub>2</sub> verschlimmert Bronchitis
- ☐ B O<sub>2</sub> ist zu teuer
- ☐ C Hypoxischer Atemantrieb: zu viel
- ☐ D Keine Kontraindikation

**116**
**Was findet man typischerweise bei einer respiratorischen Alkalose (Hyperventilation)?**

● ● ●

- ☐ A pH niedrig, pCO<sub>2</sub> hoch
- ☐ B pH hoch, HCO<sub>3</sub> stark erhöht
- ☐ C pH hoch, pCO<sub>2</sub> erniedrigt
- ☐ D alle Werte normal

**117**
**Welcher BGA-Wert ist der respiratorische (atmungsbedingte) Parameter?**

● ●

- |                                                                            |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Bikarbonat ( $\text{HCO}_3^-$ )                    | <input type="radio"/> B Base Excess |
| <input type="radio"/> C Der $\text{CO}_2$ -Partialdruck ( $\text{pCO}_2$ ) | <input type="radio"/> D Natrium     |

**118**
**Welcher pH-Bereich des arteriellen Blutes gilt als normal?**

● ●

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> A 6,8–7,0   | <input type="radio"/> B 7,35–7,45 |
| <input type="radio"/> C 7,60–7,80 | <input type="radio"/> D 8,0–8,4   |

**119**
**Welcher Normwert gilt für den arteriellen  $\text{CO}_2$ -Partialdruck ( $\text{pCO}_2$ )?**

● ●

- |                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Etwa 5–15 mmHg    | <input type="radio"/> B Etwa 80–100 mmHg |
| <input type="radio"/> C Etwa 120–140 mmHg | <input type="radio"/> D Etwa 35–45 mmHg  |

**120**
**Welche Symptome sprechen für eine Lungenembolie?**

● ● ●

- |                                                                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Plötzliche Atemnot, atemabhängiger Brustschmerz und Tachykardie | <input type="radio"/> B Über Stunden langsam zunehmende, dumpfe Schmerzen im Bauchraum |
| <input type="radio"/> C Ein ausgeprägter, großflächiger Juckreiz der gesamten Haut      | <input type="radio"/> D Ausschließlich ein anhaltender, drückender Kopfschmerz         |

## 7 Chirurgie

20 Fragen

### 121 Welchen Nutzen hat die postoperative Frühmobilisation?

- ☐ A Sie erhöht das Risiko für eine Thrombose deutlich
- ☐ B Sie dient rein kosmetischen und ästhetischen Zwecken
- ☐ C Sie senkt Thrombose-, Pneumonie- und Ileusrisiko und fördert die Darmtätigkeit
- ☐ D Sie ist nach einer Operation grundsätzlich untersagt

### 122 Welche Zeichen sprechen für eine Wundinfektion?

- ☐ A Eine blasse, kühle und trockene Umgebung der Wunde
- ☐ B Eine auffällig rasche und komplikationslose Heilung
- ☐ C Rötung, Schwellung, Überwärmung, Schmerz und ggf. eitriges Sekret
- ☐ D Das vollständige Ausbleiben jeglicher Veränderung

### 123 Was ist der postoperative Harnverhalt?

- ☐ A Die Unfähigkeit, die volle Blase spontan zu entleeren
- ☐ B Ein ungewöhnlich häufiges Wasserlassen in kleinen Mengen
- ☐ C Eine bakterielle Infektion der Operationswunde
- ☐ D Ein Verschluss des Darms mit fehlender Passage

### 124 Wie lange sollen Patienten vor einer geplanten Operation in der Regel nüchtern sein?

- ☐ A Klare Flüssigkeiten bis 2 h, feste Nahrung bis 6 h vorher
- ☐ B Gar nicht nüchtern
- ☐ C 24 Stunden komplett ohne alles
- ☐ D Nur 30 Minuten vorher

### 125 Was ist ein postoperativer (paralytischer) Ileus?

- ☐ A Eine bakterielle Infektion der frischen Operationswunde
- ☐ B Eine nach der Operation auftretende Entzündung der Lunge
- ☐ C Ein Verschluss einer Vene durch ein Blutgerinnsel
- ☐ D Ein Darmstillstand mit fehlender Peristaltik nach der OP

### 126 Wie sollte präoperativ eine notwendige Haarentfernung erfolgen?

- ☐ A Mit einer trockenen Rasur bereits am Vortag der Operation
- ☐ B Grundsätzlich gar nicht, indem die Haare herausgerissen werden
- ☐ C Mit einer scharfen Klinge lange Zeit vor dem Eingriff
- ☐ D Wenn nötig zeitnah vor der OP mit einem Clipper kürzen (keine Nassrasur mit Klinge)

**127 Wann wird eine Wunddrainage in der Regel entfernt?**

● ●

- ☐ A Unmittelbar und grundsätzlich sofort im Anschluss an die Operation
- ☐ B Wenn die Fördermenge deutlich zurückgegangen ist (nach ärztlicher Anordnung)
- ☐ C Grundsätzlich immer erst nach mehreren Wochen, unabhängig von der Fördermenge
- ☐ D Niemals, da eine liegende Wunddrainage dauerhaft im Körper verbleibt

**128 Was ist Schmerzerfassung mit NRS und wann handeln?**

● ●

- ☐ A Nur einmal täglich erheben
- ☐ B NRS 0-10, ab NRS  $\geq 4$
- ☐ C Erst auf Nachfrage erheben
- ☐ D Nur bei Schmerzen  $> 8$

**129 Was kennzeichnet eine Redon-Drainage?**

● ●

- ☐ A Eine geschlossene Saugdrainage mit Unterdruck (Sog)
- ☐ B Eine offene Drainage ohne Sog
- ☐ C Ein Blasenkatheter
- ☐ D Eine Magensonde

**130 Warum ist Wärme bei Appendizitisverdacht kontraindiziert?**

● ●

- ☐ A Wärme ist erlaubt
- ☐ B Wärme fördert Entzündung
- ☐ C Nur Kälte ist verboten
- ☐ D Es gibt keinen medizinischen Grund

**131 Was ist bei der Versorgung eines frisch angelegten Stomas (z. B. Kolostomie) wichtig?**

● ● ●

- ☐ A Die umgebende Haut möglichst kräftig und aggressiv reinigen und rubbeln
- ☐ B Das Stoma vorsichtshalber abbinden, um Ausscheidungen zu verhindern
- ☐ C Auf jegliche Beobachtung von Durchblutung und Hautzustand verzichten
- ☐ D Farbe/Durchblutung des Stomas beurteilen, Haut schützen, dichte Versorgung wählen und Betroffene anleiten

**132 Wofür steht PONV in der perioperativen Pflege?**

● ●

- ☐ A Ein bestimmter gemessener Wert des arteriellen Blutdrucks
- ☐ B Postoperative Übelkeit und Erbrechen (postoperative nausea and vomiting)
- ☐ C Ein spezieller Verbandtyp für frische Operationswunden
- ☐ D Eine bestimmte Lagerungsform des Patienten nach der Operation

**133 Was ist der McBurney-Punkt?**

● ●

- ☐ A Ein typischer Druckschmerzpunkt im Bereich der erkrankten Niere
- ☐ B Ein charakteristischer Druckpunkt über der entzündeten Gallenblase
- ☐ C Druckschmerzpunkt im rechten Unterbauch bei Appendizitis
- ☐ D Ein bestimmter Schmerzpunkt zur Beurteilung von Herzbeschwerden

**134 Worauf achtet die Pflege bei liegender Wunddrainage?**

● ●

- |                                                                                                  |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Ausschließlich auf die Farbe und Sauberkeit der Bettwäsche des Patienten | <input type="radio"/> B Auf Menge und Aussehen des Sekrets, Sog/ Durchgängigkeit und Zeichen einer Nachblutung |
| <input type="radio"/> C Auf gar nichts, da die Drainage sich vollständig selbst überwacht        | <input type="radio"/> D Nur einmal wöchentlich im Rahmen des routinemäßigen Verbandwechsels                    |

**135 Was ist Thromboseprophylaxe nach TEP?**

● ●

- |                                                                             |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Ausschließlich das Tragen von Kompressionsstrümpfen | <input type="radio"/> B Die Einhaltung von durchgehender und strenger Bettruhe |
| <input type="radio"/> C Ausschließlich die tägliche Einnahme von Aspirin    | <input type="radio"/> D NMH, Kompressionsstrümpfe und Frühmobilisation         |

**136 Warum ist die Ein- und Ausfuhrbilanz postoperativ wichtig?**

● ●

- |                                                                                           |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Ausschließlich zur zusätzlichen Beschäftigung des Pflegepersonals | <input type="radio"/> B Um Flüssigkeitshaushalt, Urinausscheidung und Drainageverluste zu überwachen |
| <input type="radio"/> C Die Bilanz ist postoperativ ohne wesentliche Bedeutung            | <input type="radio"/> D Sie ist ausschließlich bei Kindern und Säuglingen erforderlich               |

**137 Was gilt für die Einwilligung (Aufklärung) vor einer Operation?**

● ●

- |                                                                                     |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Auf eine Einwilligung kann in aller Regel verzichtet werden | <input type="radio"/> B Der Patient muss rechtzeitig aufgeklärt werden und informiert einwilligen |
| <input type="radio"/> C Über den Eingriff entscheiden grundsätzlich die Angehörigen | <input type="radio"/> D Die Aufklärung erfolgt erst nach dem Ende der Operation                   |

**138 Was wird beim Verbandwechsel an der Wunde beurteilt und dokumentiert?**

● ●

- |                                                                                                          |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Größe/Tiefe, Wundgrund, Wundränder, Sekret (Menge/Geruch) und Entzündungszeichen | <input type="radio"/> B Ausschließlich die Uhrzeit des Verbandwechsels für die fortlaufende Verlaufsdocumentation |
| <input type="radio"/> C Nur der vollständige Vor- und Nachname des Patienten zum Abgleich mit der Kurve  | <input type="radio"/> D Lediglich, ob überhaupt ein Verband vorhanden ist, ohne jede weitere Beurteilung          |

**139 Warum wird vor bestimmten Eingriffen die OP-Seite bzw. -Stelle markiert?**

●

- |                                                                                             |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Aus rein dekorativen und ästhetischen Gründen der Übersichtlichkeit | <input type="radio"/> B Vor allem, um während des Eingriffs wertvolle Zeit einzusparen |
| <input type="radio"/> C Zur Vermeidung von Eingriffsverwechslungen (Patientensicherheit)    | <input type="radio"/> D Das Markieren der Operationsstelle ist eigentlich unüblich     |

**140 Was sind typische Komplikationen nach Appendektomie?**

● ●

- |                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Wundinfektion        | <input type="radio"/> B Reine Wundschmerzen |
| <input type="radio"/> C Nur leichte Übelkeit | <input type="radio"/> D Keine               |

## 8 Pädiatrie

20 Fragen

### 141 Welchen Vorteil hat Muttermilch für Säuglinge?

- ☐ A Sie liefert bedarfsgerechte Nährstoffe und Abwehrstoffe (Nestschutz)
- ☐ B Sie ist nährstoffärmer als jede Ersatznahrung
- ☐ C Sie erhöht das Infektionsrisiko
- ☐ D Sie enthält keinerlei Antikörper

### 142 Was ist bei Scharlach zu beachten?

- ☐ A Er wird durch Viren verursacht und braucht keine Behandlung
- ☐ B Er ist nicht ansteckend
- ☐ C Er tritt nur bei Erwachsenen auf
- ☐ D Er wird durch Streptokokken verursacht und mit Antibiotika behandelt

### 143 Was sind motorische Entwicklungsmeilensteine im 1. Lebensjahr?

- ☐ A Laufen mit 6 Monaten
- ☐ B Kopfkontrolle 3 Mo., Drehen 5-6 Mo.
- ☐ C Sprechen mit 6 Monaten
- ☐ D Alle Kinder entwickeln sich gleich

### 144 Was sind die Pflichteinsatz-Stunden in der Pädiatrie laut GPA?

- ☐ A 60h
- ☐ B 240h
- ☐ C 120h
- ☐ D 500h

### 145 Welche Diabetesform tritt typischerweise im Kindes- und Jugendalter auf?

- ☐ A Diabetes Typ 2
- ☐ B Schwangerschaftsdiabetes
- ☐ C Diabetes Typ 1 (absoluter Insulinmangel)
- ☐ D Im Kindesalter kommt kein Diabetes vor

### 146 Was ist Neugeborenen-Gelbsucht (Neonataler Ikterus)?

- ☐ A Eine bakterielle oder virale Infektion des Neugeborenen
- ☐ B Physiologisch erhöhter Bilirubinwert (meist Tag 2-7)
- ☐ C Eine angeborene, genetisch bedingte Stoffwechselerkrankung
- ☐ D Eine ernsthafte Erkrankung der noch unreifen kindlichen Leber

### 147 Was ist bei der Medikamentendosierung bei Kindern zu beachten?

- ☐ A Gewichtsabhängige Dosierung
- ☐ B Gleich wie Erwachsene
- ☐ C Halbe Erwachsenendosis
- ☐ D Immer als Zäpfchen geben

**148 Was ist Fieberkrampf und wie reagiert man?**

● ●

- ☐ A Sofort mit einer vollständigen Reanimation beginnen
- ☐ B Es handelt sich grundsätzlich um eine echte Epilepsie
- ☐ C Tonisch-klonischer Krampf bei Fieber im Kindesalter
- ☐ D Die alleinige Senkung des Fiebers ist immer ausreichend

**149 Was ist Exsikkose beim Kind?**

● ●

- ☐ A Austrocknung (Dehydratation)
- ☐ B Eine hartnäckige Verstopfung mit ausbleibendem Stuhlgang
- ☐ C Ein deutliches Übergewicht des Kindes über der Altersnorm
- ☐ D Ein fieberhafter Infekt mit erhöhter Körpertemperatur

**150 Was ist Rooming-in und welche Vorteile hat es?**

● ●

- ☐ A Möglichkeit für Eltern, rund um die Uhr beim Kind zu bleiben
- ☐ B Ein hotelähnlicher Service für die begleitenden Eltern
- ☐ C Eine Möglichkeit, die ausschließlich auf der Intensivstation gilt
- ☐ D Ein Angebot, das ausschließlich den Müttern offensteht

**151 Was sind Normwerte für Atemfrequenz bei Neugeborenen?**

● ●

- ☐ A 40-60/min
- ☐ B 12-16/min
- ☐ C 30-40/min
- ☐ D 20-30/min

**152 Was sind Normwerte für Herzfrequenz bei Neugeborenen?**

● ●

- ☐ A 100-120/min
- ☐ B 120-160/min
- ☐ C 80-100/min
- ☐ D 60-80/min

**153 Was sind entwicklungsgerechte Schmerzeinschätzungsinstrumente für Kinder?**

● ●

- ☐ A KUSS, FACES-Skala, NRS
- ☐ B Kinder können keinen Schmerz äußern
- ☐ C Allein anhand der Herzfrequenz
- ☐ D Nur NRS 0-10

**154 Ab wann gilt ein Neugeborenes als Frühgeborenes?**

● ●

- ☐ A Ab einem Geburtsgewicht über 4000 g
- ☐ B Bei einer Geburt nach dem errechneten Termin
- ☐ C Nur bei Zwillingen
- ☐ D Bei Geburt vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche

**155 Wie kommuniziert man altersgerecht mit einem kranken Kind?**

● ●

- ☐ A Mit Fachbegriffen wie bei Erwachsenen
- ☐ B Indem man seine Ängste bagatellisiert
- ☐ C Indem man gar nicht mit dem Kind spricht
- ☐ D In einfacher, ehrlicher Sprache auf Augenhöhe, unter Einbezug von Spiel und Bezugsperson

**156 Was ist Pseudokrupp und wie wird er behandelt?**

● ●

- |                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Virös bedingter | <input type="radio"/> B Echte Diphtherie |
| <input type="radio"/> C Bronchitis      | <input type="radio"/> D Asthma-Anfall    |

**157 Was ist Kindesmisshandlung und welche Pflichten hat Pflegepersonal?**

● ● ●

- |                                                          |                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Betrifft nur körperliche Gewalt  | <input type="radio"/> B Nicht melden                    |
| <input type="radio"/> C Erst bei sichtbaren Verletzungen | <input type="radio"/> D Schutzauftrag nach §8a SGB VIII |

**158 Was gehört zur Unfallverhütung bei Kleinkindern?**

●

- |                                                                                         |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Steckdosen im Kinderzimmer bewusst offen und zugänglich lassen  | <input type="radio"/> B Sicherungen wie Treppengitter und Steckdosensicherungen sowie das Wegräumen von Kleinteilen und Giftstoffen |
| <input type="radio"/> C Reinigungs- und Putzmittel in Reichweite der Kinder aufbewahren | <input type="radio"/> D Kleinkinder in der Nähe von Wasser unbeaufsichtigt spielen lassen                                           |

**159 Was ist eine typische Ursache der Bronchiolitis/obstruktiven Bronchitis bei Säuglingen im Winter?**

● ● ●

- |                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Eine Nahrungsmittelallergie | <input type="radio"/> B Ein Sonnenbrand    |
| <input type="radio"/> C Eine Verletzung             | <input type="radio"/> D Das RS-Virus (RSV) |

**160 Wodurch werden Windpocken (Varizellen) verursacht?**

● ●

- |                                                          |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Durch Bakterien                  | <input type="radio"/> B Durch eine Allergie |
| <input type="radio"/> C Durch das Varizella-Zoster-Virus | <input type="radio"/> D Durch Vitaminmangel |

## 9 Gynäkologie & Geburtshilfe

20 Fragen

### 161 Warum wird unter der Geburt ein CTG geschrieben?

● ●

- ☐ A Nur zur Dokumentation
- ☐ B Um das Gewicht des Kindes zu bestimmen
- ☐ C Um den Blutdruck der Mutter zu messen
- ☐ D Um Wehentätigkeit und kindliche Herztöne zu überwachen und eine Sauerstoffunterversorgung früh zu erkennen

### 162 Warum ist der Wärmeerhalt beim Neugeborenen so wichtig?

● ●

- ☐ A Nur aus Komfortgründen
- ☐ B Das ist nur bei Frühgeborenen relevant
- ☐ C Neugeborene kühlen wegen großer Körperoberfläche und unreifer Thermoregulation schnell aus
- ☐ D Damit sie besser schlafen

### 163 Worauf muss das Neugeborene einer Mutter mit GDM nach der Geburt überwacht werden?

● ●

- ☐ A Auf Hypoglykämie (Unterzucker)
- ☐ B Auf Fieber
- ☐ C Sofort auf Übergewicht
- ☐ D Auf Bluthochdruck

### 164 Welche medikamentöse Therapie ist bei GDM Mittel der Wahl, wenn Ernährung nicht ausreicht?

● ●

- ☐ A Gar keine Therapie
- ☐ B Cortison
- ☐ C Orale Antidiabetika (Tabletten)
- ☐ D Insulin – orale Antidiabetika sind in der Schwangerschaft nicht Mittel der Wahl

### 165 Was ist die einzige kausale Therapie des HELLP-Syndroms?

● ●

- ☐ A Bettruhe
- ☐ B Abwarten bis zum Termin
- ☐ C Die Entbindung
- ☐ D Antibiotika

### 166 Wofür stehen die Kriterien im APGAR-Score?

● ●

- ☐ A Aussehen, Puls, Größe, Atmung, Reaktion
- ☐ B Alter, Puls, Gewicht, Atmung, Reflexe
- ☐ C Atmung, Puls, Grundtonus, Aussehen (Hautfarbe), Reflexe
- ☐ D Atmung, Position, Gewicht, Alter, Reflexe

### 167 Was spricht für eine korrekte Anlegetechnik?

● ●

- ☐ A Das Kind saugt nur ganz kurz
- ☐ B Die Mutter hat starke Schmerzen
- ☐ C Das Kind erfasst nur die Brustwarze
- ☐ D Das Kind erfasst Mamille und großen Teil des Warzenhofs, Lippen nach außen gestülpt

**168 Wofür steht die Abkürzung HELLP?**

● ●

- ☐ A Hypertonie, Ejektion, Laktat, Leukozyten, Puls
- ☐ B Hämolyse, erhöhte Leberwerte (Elevated Liver enzymes), niedrige Thrombozyten (Low Platelets)
- ☐ C Herz-, Leber- und Lungenproblem
- ☐ D High Energy Low Level Pressure

**169 Warum wird bei drohender Frühgeburt Kortison gegeben?**

● ●

- ☐ A Zur Lungenreifeinduktion des Kindes (Surfactant-Bildung)
- ☐ B Zur Wehenhemmung
- ☐ C Gegen Schmerzen
- ☐ D Zur Blutdrucksenkung

**170 Welche Hormone steuern die Laktation?**

● ●

- ☐ A Östrogen und Testosteron
- ☐ B Cortisol und Thyroxin
- ☐ C Prolaktin (Milchbildung) und Oxytocin (Milchflussreflex)
- ☐ D Insulin und Adrenalin

**171 Wie geht man bei einer beginnenden Mastitis in der Regel vor?**

● ●

- ☐ A Nur kühlen und nicht mehr anlegen
- ☐ B Sofort komplett abstillen
- ☐ C Gar nichts unternehmen
- ☐ D In der Regel weiterstillen/entleeren, kühlen und schonen – bei Bedarf Antibiose

**172 Worauf ist nach einer Sectio pflegerisch besonders zu achten?**

● ●

- ☐ A Nur auf die Wunde
- ☐ B Strikte Bettruhe für zwei Wochen
- ☐ C Sofortiges Abstillen
- ☐ D Konsequente Thromboseprophylaxe – das Risiko ist nach OP und im Wochenbett erhöht

**173 Wann wird die U1 durchgeführt?**

● ●

- ☐ A Direkt nach der Geburt
- ☐ B Nach sechs Wochen
- ☐ C Am 10. Lebenstag
- ☐ D Nur bei Auffälligkeiten

**174 Welche sind sichere Zeichen des Geburtsbeginns?**

● ●

- ☐ A Vermehrter Appetit
- ☐ B Sodbrennen und Übelkeit
- ☐ C Regelmäßige, zunehmende Wehen, Blasensprung und Zeichen
- ☐ D Nur Rückenschmerzen

**175 Welches ist ein typisches Leitsymptom des HELLP-Syndroms?**

● ●

- ☐ A Schmerzen im linken Bein
- ☐ B Ohrenscherzen
- ☐ C Halsschmerzen
- ☐ D Rechtsseitiger Oberbauchschmerz (Leberkapselspannung)

**176 Wann wird das Screening auf Gestationsdiabetes (oGTT) durchgeführt?**

● ●

- ☐ A Immer im ersten Trimenon
- ☐ B In der 6. SSW
- ☐ C In der 24. bis 28. SSW
- ☐ D Erst nach der Geburt

**177 Ist Stillen nach einem Kaiserschnitt möglich?**

● ●

- ☐ A Nein, grundsätzlich nicht
- ☐ B Erst nach sechs Wochen
- ☐ C Nur mit Medikamenten
- ☐ D Ja – möglich, oft aber anfangs erschwert und mit Unterstützung

**178 Was ist eine typische Indikation für eine Not-Section?**

● ●

- ☐ A Wunsch nach schnellerer Geburt
- ☐ B Leichte, unregelmäßige Wehen
- ☐ C Akute Gefährdung des Kindes, z. B. pathologisches CTG mit drohender Hypoxie
- ☐ D Alleinige Erschöpfung der Mutter

**179 In welcher Reihenfolge verlaufen die Geburtsphasen?**

● ●

- ☐ A Nachgeburt – Eröffnung – Austreibung
- ☐ B Austreibung – Eröffnung – Nachgeburt
- ☐ C Es gibt nur eine einzige Phase
- ☐ D Eröffnungsphase – Austreibungsphase – Nachgeburtsphase

**180 Ab wann spricht man von einer Frühgeburt?**

● ●

- ☐ A Jede Geburt per Sectio
- ☐ B Geburt nach der 42. SSW
- ☐ C Geburt vor der 40. SSW
- ☐ D Geburt vor abgeschlossener 37. SSW (vor 37+0)

## 10 Psychiatrie

20 Fragen

### 181 Was ist Demenz und wie unterscheidet sie sich von Depression?

● ● ●

- ☐ A Demenz ist heilbar
- ☐ B Demenz = organischer
- ☐ C Depression ist schwerer
- ☐ D Beide gleich

### 182 Was ist eine Borderline-Persönlichkeitsstörung?

● ● ●

- ☐ A Eine Form der Schizophrenie
- ☐ B Eine Depression
- ☐ C Instabile Identität
- ☐ D Eine Angststörung

### 183 Was ist eine Panikattacke und wie reagiert man als Pflegeperson?

● ●

- ☐ A Akuter Angstanfall mit Herzrasen, Atemnot und Schwindel
- ☐ B Grundsätzlich und sofort den Notarzt hinzurufen
- ☐ C Selbst einen Herzinfarkt vortäuschen zur Beruhigung
- ☐ D Den betroffenen Patienten während des Anfalls allein lassen

### 184 Was ist Schizophrenie und welche Symptome hat sie?

● ●

- ☐ A Eine gesplante Doppelpersönlichkeit mit zwei Identitäten
- ☐ B Psychische Erkrankung mit Positiv- und Negativsymptomen
- ☐ C Eine Aufspaltung der Persönlichkeit in mehrere Anteile
- ☐ D Wiederkehrende, deutliche Schwankungen der Stimmung

### 185 Was ist De-Eskalation in der Psychiatrie?

● ●

- ☐ A Fixierung sofort
- ☐ B Aggression verstärken
- ☐ C Medikamente zwangsweise
- ☐ D Systematische Deeskalation

### 186 Was ist Suizidalität und welche Stufen gibt es?

● ● ●

- ☐ A Kommt nur bei Depression vor
- ☐ B Ist meist nur Simulation
- ☐ C Passive Suizidgedanken → konkrete Pläne → Suizidversuch
- ☐ D Nicht ernst nehmen

### 187 Was bedeutet Einwilligungsfähigkeit im psychiatrischen Kontext?

● ● ●

- ☐ A Sie ist automatisch mit dem Erreichen der Volljährigkeit gegeben
- ☐ B Die Fähigkeit, Art, Bedeutung und Tragweite einer Maßnahme zu verstehen und frei zu entscheiden
- ☐ C Sie ist völlig gleichbedeutend mit der Geschäftsfähigkeit
- ☐ D Sie liegt in der Zustimmung der nächsten Angehörigen

**188 Was sind die Pflichteinsatz-Stunden in der Psychiatrie laut GPA?**

- ☐ A 500h
- ☐ B 240h
- ☐ C 120h
- ☐ D 60h

**189 Was ist therapeutische Kommunikation in der Psychiatrie?**

- ☐ A Die gezielte Ablenkung des Patienten von seinen Problemen
- ☐ B Empathische, wertschätzende und nicht-wertende Gesprächsführung
- ☐ C Klare, direktive Anweisungen und Vorgaben an den Patienten
- ☐ D Die reine Verabreichung der verordneten Medikamente

**190 Was ist Milieuthherapie in der Psychiatrie?**

- ☐ A Therapeutische Gestaltung der gesamten Stationsumgebung
- ☐ B Eine Form der Umwelttherapie mit Aufenthalt in der Natur
- ☐ C Eine ausschließlich im Einzelsetting durchgeführte Therapie
- ☐ D Eine reine Behandlung allein durch die Gabe von Medikamenten

**191 Was ist das Ziel einer Krisenintervention?**

- ☐ A Die langfristige ambulante Psychotherapie vollständig zu ersetzen
- ☐ B Kurzfristige Stabilisierung und Entlastung in einer akuten seelischen Ausnahmesituation
- ☐ C Die sofortige Fixierung und Ruhigstellung des Betroffenen
- ☐ D Die akute seelische Krise bewusst zu übergehen und abzuwarten

**192 Was zählt zur Negativsymptomatik der Schizophrenie?**

- ☐ A Ausgeprägter Wahn mit festen, durch Argumente nicht korrigierbaren Überzeugungen
- ☐ B Optische und akustische Halluzinationen ohne einen erkennbaren realen Auslöser
- ☐ C Ich-Störungen mit dem quälenden Gefühl von außen eingegebener fremder Gedanken
- ☐ D Antriebsmangel, sozialer Rückzug und Affektverflachung

**193 Was ist ein Alkoholentzugsdelir (Delirium tremens)?**

- ☐ A Eine lebensbedrohliche Entzugskomplikation mit Verwirrtheit, Zittern, Halluzinationen und vegetativen Symptomen
- ☐ B Ein vorübergehender, im Grunde harmloser Kater nach Alkoholkonsum
- ☐ C Eine leichte, rasch abklingende Kopfschmerzphase ohne weitere Folgen
- ☐ D Ein völlig normaler und ungefährlicher Schlafzustand während des Entzugs

**194 Was ist bei psychiatrischer Zwangsbehandlung rechtlich zu beachten?**

- ☐ A Sie ist jederzeit ohne weitere Voraussetzungen möglich
- ☐ B Sie ist in jedem Fall und ohne Einschränkung erlaubt
- ☐ C Nur mit richterlicher Genehmigung bei Eigen-/Fremdgefährdung (PsychKG)
- ☐ D Das Pflegepersonal entscheidet darüber eigenständig allein

**195 Welches Risiko besteht bei längerer Einnahme von Benzodiazepinen?**

● ●

- ☐ A Die Entwicklung einer Abhängigkeit
- ☐ B Gar keine Nebenwirkungen
- ☐ C Eine sofortige Heilung von Angst
- ☐ D Blutdruckanstieg als Hauptwirkung

**196 Was ist das Konzept der Psychoedukation?**

● ●

- ☐ A Ergotherapie
- ☐ B Verhaltenstherapie
- ☐ C Psychiatrie-Studium
- ☐ D Strukturierte

**197 Welchen therapeutischen Zweck hat eine klare Tagesstrukturierung?**

●

- ☐ A Sie dient ausschließlich der organisatorischen Ordnung der Station
- ☐ B Sie gibt Orientierung, Sicherheit und Halt und fördert Aktivierung und Selbstständigkeit
- ☐ C Sie wirkt sich bei einer Depression eher schädlich aus
- ☐ D Sie kann die Gabe von Medikamenten vollständig ersetzen

**198 Was unterscheidet ein Delir von einer Demenz?**

● ●

- ☐ A Beide Störungsbilder beginnen gleichermaßen langsam und schleichend
- ☐ B Das Delir beginnt akut und ist meist reversibel, die Demenz entwickelt sich langsam und chronisch
- ☐ C Das Delir ist grundsätzlich ein dauerhafter, bleibender Zustand
- ☐ D Die Demenz tritt typischerweise ganz plötzlich über Nacht auf

**199 Was sind extrapyramidale Nebenwirkungen (EPS) von Antipsychotika?**

● ● ●

- ☐ A Beschwerden im Bereich von Magen und Darm mit Übelkeit und Durchfall
- ☐ B Verschiedene Formen von Hautausschlägen mit Rötung und Juckreiz
- ☐ C Bewegungsstörungen wie Frühdyskinesien, Parkinsonoid oder Akathisie
- ☐ D Ausschließlich vorübergehende Störungen des Sehvermögens

**200 Was ist bei einer akuten Intoxikation (z. B. Alkohol, Drogen) pflegerisch vorrangig?**

● ●

- ☐ A Vitalzeichen und Bewusstsein überwachen, Aspiration und Atemdepression vorbeugen
- ☐ B Sofort und vorrangig ein ausführliches Deeskalationsgespräch führen
- ☐ C Den betroffenen Patienten aktiv zum Aufstehen und Gehen zwingen
- ☐ D Dem Patienten zur Stärkung zunächst reichlich Nahrung anbieten

## 11 Psychologie & Kommunikation

20 Fragen

### 201 Was beschreibt Maslows Bedürfnispyramide? ● ●

- |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><input type="radio"/> A Fünf aufeinander aufbauende Stufen der zwischenmenschlichen Kommunikation im Team</p> <p><input type="radio"/> C Fünf Stufen der Stressverarbeitung vom auslösenden Reiz bis zur körperlichen Reaktion</p> | <p><input type="radio"/> B Fünf grundlegende Lerntypen mit jeweils unterschiedlichen Zugangs- und Verarbeitungswegen</p> <p><input type="radio"/> D Hierarchie: physiologische Bedürfnisse → Sicherheit → Soziales → Wertschätzung → Selbstverwirklichung</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 202 Was ist das Grundanliegen der Basalen Stimulation? ● ● ●

- |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><input type="radio"/> A Durch möglichst viele gleichzeitige Sinnesreize eine bewusst anregende Reizüberflutung erzeugen</p> <p><input type="radio"/> C Die betroffenen Menschen vorrangig medikamentös ruhigstellen und äußere Reize gänzlich vermeiden</p> | <p><input type="radio"/> B Wahrnehmung, Kommunikation und Bewegung über gezielte Sinnesreize fördern (v. a. bei stark eingeschränkten Menschen)</p> <p><input type="radio"/> D Den direkten körperlichen Kontakt zum betroffenen Menschen möglichst weitgehend gering halten</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 203 Was ist motivierende Gesprächsführung (Motivational Interviewing)? ● ● ●

- |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><input type="radio"/> A Eine direktive Beratung mit klaren Vorgaben an den Patienten</p> <p><input type="radio"/> C Patientenzentriert: Autonomie und eigene Motivation stärken</p> | <p><input type="radio"/> B Die reine Vermittlung von Informationen und Fakten</p> <p><input type="radio"/> D Das gezielte Überreden des Patienten zu einer Entscheidung</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 204 Was besagt das 4-Ohren-Modell nach Schulz von Thun? ● ●

- |                                                                                                                         |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><input type="radio"/> A 4 Fehler in der Kommunikation</p> <p><input type="radio"/> C Jede Nachricht hat 4 Seiten</p> | <p><input type="radio"/> B 4 Phasen der Kommunikation</p> <p><input type="radio"/> D 4 Kommunikationsstile</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 205 Was betont das transaktionale Stressmodell nach Lazarus? ● ● ●

- |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><input type="radio"/> A Der erlebte Stress hängt ausschließlich von der äußeren Situation selbst ab</p> <p><input type="radio"/> C Entscheidend ist die persönliche Bewertung einer Situation und die verfügbaren Bewältigungsmöglichkeiten</p> | <p><input type="radio"/> B Stress wirkt sich auf den Menschen grundsätzlich und in jedem Fall schädlich aus</p> <p><input type="radio"/> D Der erlebte Stress lässt sich durch den Betroffenen selbst überhaupt nicht beeinflussen</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 206 Was ist Gewaltfreie Kommunikation (GFK) nach Rosenberg? ● ●

- |                                                                                                                                         |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><input type="radio"/> A 4 Schritte: Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte</p> <p><input type="radio"/> C Konfliktmanagement-Kurs</p> | <p><input type="radio"/> B Schweigen bei Konflikten</p> <p><input type="radio"/> D Kommunikation ohne Schreien</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**207 Was sind die 3 Burnout-Kernkomponenten nach Maslach?**

● ●

- |                                                                                           |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Emotionale Erschöpfung, Depersonalisation und reduzierte Leistung | <input type="radio"/> B Müdigkeit, Kopfschmerz, Rücken |
| <input type="radio"/> C Stress, Konflikte, Überstunden                                    | <input type="radio"/> D Depression, Angst, Panik       |

**208 Was ist eine Ich-Botschaft in der Kommunikation?**

● ●

- |                                                                                              |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Ein deutlicher Vorwurf an den anderen ('Du machst das immer falsch') | <input type="radio"/> B Eine klare Anweisung oder ein Befehl an das Gegenüber                             |
| <input type="radio"/> C Bewusstes Schweigen, um dem anderen keine Angriffsfläche zu bieten   | <input type="radio"/> D Das Ausdrücken eigener Wahrnehmung und Gefühle ('Ich habe den Eindruck, dass...') |

**209 Welche drei Grundhaltungen kennzeichnen die personenzentrierte Gesprächsführung nach Rogers?**

● ● ●

- |                                                                                         |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Autorität, Distanz, Kontrolle                                   | <input type="radio"/> B Belehrung, Wertung, Ratschlag   |
| <input type="radio"/> C Empathie, Kongruenz (Echtheit) und bedingungslose Wertschätzung | <input type="radio"/> D Schweigen, Ignorieren, Ablenken |

**210 Was ist Supervision in der Pflege?**

● ●

- |                                                     |                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Professionelle Reflexion    | <input type="radio"/> B Eine Leistungsbeurteilung |
| <input type="radio"/> C Kontrolle durch Vorgesetzte | <input type="radio"/> D Ein Ausbildungspraktikum  |

**211 Was ist das Transtheoretische Modell (TTM)?**

● ● ●

- |                                                          |                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A 5 Stadien der Verhaltensänderung | <input type="radio"/> B Kommunikationsmodell |
| <input type="radio"/> C Lernmodell                       | <input type="radio"/> D Stressmodell         |

**212 Wozu dient Biografiearbeit in der Pflege?**

● ●

- |                                                                                                                         |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Zur reinen Sammlung von Daten ohne weiteren praktischen Nutzen                                  | <input type="radio"/> B Zur Überwachung und Kontrolle des Verhaltens der Patienten      |
| <input type="radio"/> C Die Lebensgeschichte zu nutzen, um individuell, sinnstiftend und bedürfnisorientiert zu pflegen | <input type="radio"/> D Um vergangene Ereignisse im Leben zu bewerten und zu beurteilen |

**213 Was hilft in der Kommunikation mit hörgeschädigten Menschen?**

●

- |                                                                                                                                  |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Deutlich und zugewandt sprechen, Blickkontakt halten, ruhige Umgebung, ggf. Schrift oder Gebärden nutzen | <input type="radio"/> B Von hinten sprechen, damit der Schall den Raum besser ausfüllt     |
| <input type="radio"/> C Möglichst schnell und viel sprechen, um alle Informationen zu vermitteln                                 | <input type="radio"/> D Beim Sprechen den Mund mit der Hand verdecken, um leiser zu wirken |

**214 Was besagt das Axiom 'Man kann nicht nicht kommunizieren' (Watzlawick)?**

● ●

- ☐ A Nur bewusst gesprochene Worte gelten als echte Kommunikation
- ☐ B Jedes Verhalten hat Mitteilungscharakter – auch Schweigen oder Wegsehen wirkt kommunikativ
- ☐ C Die Kommunikation ist für das Miteinander im Grunde unwichtig
- ☐ D Ausschließlich schriftlich Festgehaltenes zählt als Kommunikation

**215 Was ist aktives Zuhören?**

●

- ☐ A Verbale und nonverbale Zuwendung mit Paraphrasieren
- ☐ B Den Patienten einfach ungestört ausreden zu lassen
- ☐ C Während des Gesprächs lediglich zustimmend zu nicken
- ☐ D Dem Gegenüber schweigend und ohne Reaktion zuzuhören

**216 Was bedeutet Empathie in der Pflege?**

●

- ☐ A Ein Mitgefühl, das die Pflegekraft handlungsunfähig macht
- ☐ B Die Fähigkeit, sich in die Gefühle und Sichtweise des anderen einzufühlen
- ☐ C Eine grundsätzliche Gleichgültigkeit gegenüber dem Patienten
- ☐ D Das konsequente Durchsetzen der eigenen Meinung

**217 Was gehört zur nonverbalen Kommunikation?**

●

- ☐ A Die Rechtschreibung und die Grammatik des Geschriebenen
- ☐ B Mimik, Gestik, Körperhaltung, Blickkontakt und Tonfall
- ☐ C Ausschließlich der reine inhaltliche Sinn der gesprochenen Worte
- ☐ D Die verwendete E-Mail-Adresse und Telefonnummer

**218 Welche Frühzeichen können auf berufliche Überlastung hinweisen?**

● ●

- ☐ A Ein deutlicher Zuwachs an Energie und beruflicher Freude
- ☐ B Eine spürbar verbesserte Konzentration und Leistungsfähigkeit
- ☐ C Anhaltende Erschöpfung, Zynismus, Schlafstörungen und Rückzug
- ☐ D Keinerlei erkennbare Veränderung im Befinden der Person

**219 Was ist im Umgang mit sehbehinderten oder blinden Menschen wichtig?**

●

- ☐ A Wortlos und ohne jede Ankündigung am Menschen zu handeln
- ☐ B Sich der Person unbemerkt von hinten zu nähern und sie zu erschrecken
- ☐ C Gegenstände unangekündigt aus ihrer Reichweite zu entfernen
- ☐ D Sich mit Namen ansprechen und vorstellen, Handlungen ankündigen und beschreiben

**220 Was ist Progressive Muskelrelaxation (PMR)?**

● ●

- ☐ A Eine Sportart
- ☐ B Stressbewältigungstechnik
- ☐ C Eine Massagetechnik
- ☐ D Ein Atemkonzept

## 12 Altenpflege & Geriatrie

20 Fragen

### 221 Wozu dienen Kurzzeit- und Verhinderungspflege?

● ●

- |                                                                                                     |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Zur vorübergehenden Entlastung pflegender Angehöriger bzw. zur Überbrückung | <input type="radio"/> B Der dauerhaften Unterbringung im Pflegeheim        |
| <input type="radio"/> C Ausschließlich der medizinischen Rehabilitation                             | <input type="radio"/> D Der Finanzierung von Umbaumaßnahmen in der Wohnung |

### 222 Was regelt das Betreuungsrecht und wann greift es?

● ● ●

- |                                                                                                |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Rechtliche Betreuung für nicht mehr selbst handlungsfähige Volljährige | <input type="radio"/> B Den Abschluss und die Inhalte eines Heimvertrags |
| <input type="radio"/> C Die Vormundschaft für noch minderjährige Kinder                        | <input type="radio"/> D Die Feststellung und Einstufung des Pflegegrades |

### 223 Was ist Mangelernährung im Alter und wie wird sie erkannt?

● ●

- |                                         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Selten im Alter | <input type="radio"/> B Unzureichende Nährstoffzufuhr   |
| <input type="radio"/> C Übergewicht     | <input type="radio"/> D Tritt nur bei Bettlägerigen auf |

### 224 Was ist Biografiearbeit und warum ist sie in der Altenpflege wichtig?

● ●

- |                                                                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Eine möglichst lückenlose pflegerische Verlaufsdokumentation | <input type="radio"/> B Die vollständige medizinische Vorgeschichte des Patienten       |
| <input type="radio"/> C Die Erhebung der Erkrankungen innerhalb der Familie          | <input type="radio"/> D Lebensgeschichte, Gewohnheiten und prägende Erlebnisse erfassen |

### 225 Was ist bei der Hautpflege alter Menschen zu beachten?

●

- |                                                                                                              |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Die Haut ist dünner und trockener, daher schonende Reinigung und rückfettende Pflege | <input type="radio"/> B Möglichst heiß und lange baden          |
| <input type="radio"/> C Häufiges Waschen mit stark entfettender Seife                                        | <input type="radio"/> D Die Haut braucht keine besondere Pflege |

### 226 Was ist das Neue Begutachtungsassessment (NBA)?

● ●

- |                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Begutachtungsinstrument | <input type="radio"/> B Ein Pflegeplan |
| <input type="radio"/> C Eine Pflegediagnose     | <input type="radio"/> D Ein Labortest  |

### 227 Was ist Demenz und welche Formen gibt es?

● ●

- |                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Kurzzeitgedächtnisschwäche | <input type="radio"/> B Erworbener kognitiver Abbau |
| <input type="radio"/> C Normales Altern            | <input type="radio"/> D Depression                  |

**228 Wie kann sich eine Depression im Alter von einer Demenz unterscheiden?**

● ● ●

- |                                                                                                                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Bei der Depression klagen Betroffene oft selbst über die Beschwerden, während sie bei Demenz eher überspielt werden | <input type="radio"/> B Depression und Demenz sind in ihrem Erscheinungsbild vollständig identisch      |
| <input type="radio"/> C Eine Depression tritt im höheren Lebensalter grundsätzlich nicht mehr auf                                           | <input type="radio"/> D Eine Demenz ist bei rechtzeitiger Behandlung in aller Regel vollständig heilbar |

**229 Was bedeutet Multimorbidität?**

●

- |                                                        |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Eine einzelne akute Erkrankung | <input type="radio"/> B Das gleichzeitige Bestehen mehrerer chronischer Erkrankungen |
| <input type="radio"/> C Eine ansteckende Krankheit     | <input type="radio"/> D Ein einmaliger Sturz                                         |

**230 Was ist Sterbebegleitung und welche Zeichen des Sterbens sind zu beobachten?**

● ●

- |                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Aktive Begleitung: Mundpflege | <input type="radio"/> B Arzt anrufen und warten |
| <input type="radio"/> C Sofort Reanimation            | <input type="radio"/> D Nichts tun              |

**231 Was ist das Heimgesetz NRW (WTG) und was regelt es?**

● ● ●

- |                                                  |                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Wohn- und Teilhabegesetz | <input type="radio"/> B Regelung der Pflegeausbildung |
| <input type="radio"/> C Krankenhaus-Gesetze      | <input type="radio"/> D Ambulante Pflege              |

**232 Was ist Inkontinenz und welche Formen gibt es?**

● ●

- |                                                                              |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Ausschließlich neurologisch bedingt                  | <input type="radio"/> B Ausschließlich unkontrollierter Stuhlabgang |
| <input type="radio"/> C Belastungs-, Drang-, Überlauf- und Reflexinkontinenz | <input type="radio"/> D Normales Altern                             |

**233 Was ist der Expertenstandard Sturzprophylaxe?**

● ●

- |                                                                                       |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Die Anordnung von durchgehender und strenger Bettruhe         | <input type="radio"/> B Die vorbeugende Fixierung der sturzgefährdeten Person  |
| <input type="radio"/> C Risikoeinschätzung und individuelle Sturzpräventionsmaßnahmen | <input type="radio"/> D Das durchgehende Hochstellen der seitlichen Bettgitter |

**234 Was ist eine Patientenverfügung?**

● ●

- |                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Testamentsverfügung           | <input type="radio"/> B Heimvertrag               |
| <input type="radio"/> C Schriftliche Willensbekundung | <input type="radio"/> D Krankenversicherungskarte |

**235 Was ist Kinästhetik und ihre Bedeutung in der Altenpflege?**

● ●

- |                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Bewegungslehre | <input type="radio"/> B Ergotherapie  |
| <input type="radio"/> C Physiotherapie | <input type="radio"/> D Sporttherapie |

**236 Was ist Validation nach Naomi Feil in der Altenpflege?**

● ●

- |                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Schmerzmessung   | <input type="radio"/> B Kommunikationsmethode |
| <input type="radio"/> C Lagerungstechnik | <input type="radio"/> D Wundbehandlung        |

**237 Was ist das SGB XI und welche Leistungen gibt es?**

● ● ●

- |                                                  |                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Arbeitslosenversicherung | <input type="radio"/> B Rentenversicherung         |
| <input type="radio"/> C Krankenversicherung      | <input type="radio"/> D Soziale Pflegeversicherung |

**238 Was kann die Nahrungsaufnahme bei Menschen mit Demenz unterstützen?**

● ●

- |                                                        |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Große, komplizierte Menüs      | <input type="radio"/> B Essen unter Zeitdruck                                    |
| <input type="radio"/> C Ablenkung durch laute Umgebung | <input type="radio"/> D Fingerfood, vertraute Speisen, Ruhe und ausreichend Zeit |

**239 Was ist der Unterschied zwischen ambulanter und stationärer Altenpflege?**

● ●

- |                                                                             |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Ambulant = Pflege zu Hause durch einen Pflegedienst | <input type="radio"/> B Beide finden im Pflegeheim statt |
| <input type="radio"/> C Stationär ist immer besser                          | <input type="radio"/> D Ambulant ist teurer              |

**240 Was ist Dysphagie und welche Pflegemaßnahmen gibt es?**

● ● ●

- |                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="radio"/> A Verstopfung | <input type="radio"/> B Schluckstörung  |
| <input type="radio"/> C Durst       | <input type="radio"/> D Harninkontinenz |

## 13 Palliativpflege

20 Fragen

### 241 Was unterscheidet ein stationäres Hospiz von einer Palliativstation?

- ☐ A Hospiz ist Teil des Krankenhauses
- ☐ B Palliativstation ist im Krankenhaus, Hospiz ist eigenständig
- ☐ C Beide sind identisch
- ☐ D Hospiz nur für Kinder

### 242 Wie geht man mit Hoffnungen und Wünschen eines Sterbenden um?

- ☐ A Sie sofort als unrealistisch abtun
- ☐ B Sie konsequent ignorieren
- ☐ C Sie den Angehörigen ausreden lassen
- ☐ D Sie ernst nehmen und wertschätzend darauf eingehen

### 243 Was versteht man unter palliativer Sedierung?

- ☐ A Die gezielte Herbeiführung des Todes
- ☐ B Den kompletten Verzicht auf jede Medikation
- ☐ C Das kontrollierte Herabsetzen des Bewusstseins zur Linderung sonst unstillbarer Symptome
- ☐ D Eine Vollnarkose zur Operation

### 244 Was regelt eine Vorsorgevollmacht?

- ☐ A Sie bevollmächtigt eine benannte Vertrauensperson, im Ernstfall für einen zu entscheiden
- ☐ B Sie legt nur die Bestattungsart fest
- ☐ C Sie ersetzt das Testament
- ☐ D Sie ist nur für Ärzte bindend, nicht für Angehörige

### 245 Wozu dient eine Betreuungsverfügung?

- ☐ A Zur Festlegung der Erbfolge
- ☐ B Zur Bestimmung des Sterbeortes
- ☐ C Zur Regelung der Organspende
- ☐ D Als Wunsch, wen das Gericht bei Bedarf als Betreuer bestellen soll

### 246 Wie geht man mit Ernährung und Flüssigkeit in der Sterbephase um?

- ☐ A Nahrung und Flüssigkeit nicht erzwingen, sondern an Bedürfnis und Wohlbefinden ausrichten
- ☐ B Grundsätzlich in jedem Fall eine Magensonde zur Ernährung legen
- ☐ C Zur Flüssigkeitszufuhr immer eine Dauerinfusion anhängen
- ☐ D Die Aufnahme fester Nahrung aktiv einfordern und erzwingen

### 247 Warum ist es wichtig, Angehörigen Zeit zum Abschied am Verstorbenen zu geben?

- ☐ A Damit die Formalitäten schneller gehen
- ☐ B Aus rein rechtlichen Gründen
- ☐ C Weil ein bewusster Abschied die Trauerverarbeitung unterstützt
- ☐ D Es ist eigentlich unwichtig

**248 Welche Maßnahme lindert Atemnot in der Palliativsituation?**

● ●

- ☐ A Eine flache Rückenlagerung ganz ohne Erhöhung des Oberkörpers
- ☐ B Eine kurze, kühle Reizdusche zur allgemeinen Kreislaufanregung
- ☐ C Ein konsequentes Bewegungsverbot zur vollständigen Schonung
- ☐ D Oberkörperhochlagerung, Frischluft, ggf. Opiode

**249 Was ist bei der Trauerbegleitung von Angehörigen wichtig?**

● ●

- ☐ A Trauer zulassen und individuell begleiten
- ☐ B Trauer schnell beenden
- ☐ C Kontakt vermeiden
- ☐ D Ausschließlich mit Medikamenten behandeln

**250 Welches ist ein unsicheres Todeszeichen?**

● ●

- ☐ A Die eingetretene und deutlich ausgeprägte Totenstarre des Körpers
- ☐ B Die sichtbaren Totenflecken an den tiefliegenden Körperpartien
- ☐ C Die einsetzenden Fäulnis- und Zersetzungserscheinungen
- ☐ D Fehlende Atmung und fehlender Puls

**251 Welche Grundhaltung ist in der Sterbebegleitung besonders wichtig?**

● ●

- ☐ A Präsenz und Dasein – aushalten, zuhören und nicht alleinlassen
- ☐ B Möglichst viele Maßnahmen durchführen
- ☐ C Sich emotional völlig zurückziehen
- ☐ D Ständig Ratschläge geben

**252 Wie sollte man mit einem Sterbenden über seine Situation sprechen?**

● ●

- ☐ A Ihn grundsätzlich anlügen, um ihn zu schonen
- ☐ B Jedes Gespräch über das Sterben vermeiden
- ☐ C Nur mit den Angehörigen, nie mit ihm selbst
- ☐ D Ehrlich, einfühlsam und im Tempo des Betroffenen

**253 Was regelt eine Patientenverfügung?**

● ●

- ☐ A Die Verteilung des Erbes und die Regelung aller offenen Vermögensangelegenheiten
- ☐ B Die Übernahme und die genaue Aufteilung der entstehenden Pflege- und Heimkosten
- ☐ C Die persönlichen Wünsche zur Bestattung und zur Gestaltung der Trauerfeier
- ☐ D Medizinische Behandlungswünsche für den Fall der Einwilligungsunfähigkeit

**254 Welche Lagerung erleichtert einem palliativen Patienten mit Atemnot das Atmen?**

● ●

- ☐ A Eine flache Rückenlage ganz ohne jede Erhöhung des Oberkörpers
- ☐ B Eine Kopftieflagerung zur Förderung der Durchblutung des Gehirns
- ☐ C Eine durchgehende Bauchlage zur gezielten Entlastung des unteren Rückens
- ☐ D Eine Oberkörperhochlagerung, ggf. mit Armabstützung (atemerleichternde Position)

**255 Was lindert das Durstgefühl eines sterbenden Menschen am besten?**

● ●

- ☐ A Regelmäßige, sorgfältige Mundpflege und Befeuchten der Lippen
 ☐ B Möglichst große Infusionsmengen
 ☐ C Salzige Speisen
 ☐ D Vollständiger Verzicht auf Mundpflege

**256 Welche Medikamente werden bei neuropathischen Schmerzen häufig ergänzend (als Ko-Analgetika) eingesetzt?**

● ● ●

- ☐ A Nur klassische Schmerzmittel wie Paracetamol
 ☐ B Ausschließlich Opioide
 ☐ C Bestimmte Antidepressiva und Antikonvulsiva
 ☐ D Reine Vitaminpräparate

**257 Womit lindert man Übelkeit und Erbrechen in der Palliativversorgung?**

● ●

- ☐ A Mit möglichst viel Nahrung auf einmal
 ☐ B Mit Antiemetika nach ärztlicher Anordnung, angepasst an die Ursache
 ☐ C Ausschließlich mit strikter Bettruhe
 ☐ D Durch tagelanges Nüchternlassen

**258 Wie geht man mit terminaler Rasselatmung um?**

● ●

- ☐ A Lagerung, Aufklärung der Angehörigen, ggf. Anticholinergika
 ☐ B Möglichst aggressiv und in kurzen Abständen wiederholt absaugen
 ☐ C Den Patienten dafür durchgehend flach auf dem Rücken lagern
 ☐ D Den Patienten grundsätzlich tief und dauerhaft sedieren

**259 Welche Nebenwirkung tritt regelhaft unter Opioiden auf und muss prophylaktisch behandelt werden?**

● ●

- ☐ A Durchfall
 ☐ B Haarausfall
 ☐ C Obstipation
 ☐ D Fieber

**260 Was gehört zur spirituellen Begleitung am Lebensende?**

● ●

- ☐ A Ausschließlich medikamentöse Therapie
 ☐ B Nur die Regelung finanzieller Fragen
 ☐ C Das Eingehen auf Sinnfragen, Glauben und persönliche Werte, ggf. mit Seelsorge
 ☐ D Das Ignorieren religiöser Bedürfnisse

## 14 Rehabilitation

20 Fragen

### 261 Welche Berufsgruppe ist für die Schlucktherapie bei Dysphagie zuständig?

● ●

- ☐ A Die Orthopädie
- ☐ B Die Radiologie
- ☐ C Die Logopädie
- ☐ D Die Dermatologie

### 262 Warum bezieht man Angehörige in die Rehabilitation ein?

● ●

- ☐ A Um sie über Kosten zu informieren
- ☐ B Um ihnen alle Aufgaben allein zu übergeben
- ☐ C Angehörige sollten grundsätzlich herausgehalten werden
- ☐ D Um sie anzuleiten und Reha-Erfolge in den Alltag zu übertragen

### 263 Was ist eine Anschlussrehabilitation (AHB)?

●

- ☐ A Eine dauerhafte ambulante Versorgung im häuslichen Umfeld
- ☐ B Ein Kuraufenthalt ganz ohne medizinische Notwendigkeit
- ☐ C Ein Aufenthalt in einem Hospiz in der letzten Lebensphase
- ☐ D Reha unmittelbar nach einem Krankenhausaufenthalt

### 264 Was kennzeichnet aktivierend-therapeutische Pflege in der Rehabilitation?

● ●

- ☐ A Therapeutische Prinzipien in Pflegehandlungen integrieren
- ☐ B Vollständige Übernahme aller Tätigkeiten
- ☐ C Reine Beobachtung ohne Eingreifen
- ☐ D Strikte Bettruhe

### 265 Was ist das zentrale Ziel von Leistungen zur Teilhabe (SGB IX)?

● ●

- ☐ A Selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
- ☐ B Klinikaufenthalt verlängern
- ☐ C Pflegegrad erhöhen
- ☐ D Medikamente reduzieren

### 266 Was bedeutet der Grundsatz der aktivierenden Pflege?

●

- ☐ A Dem Patienten alle Tätigkeiten abnehmen
- ☐ B Den Patienten möglichst schonen und liegen lassen
- ☐ C Hilfe zur Selbsthilfe – nur so viel Unterstützung wie nötig
- ☐ D Alles möglichst schnell für den Patienten erledigen

### 267 Was erfasst der FIM (Functional Independence Measure)?

● ● ●

- ☐ A Ausschließlich die maximal mögliche Gehstrecke des Patienten in zurückgelegten Metern
- ☐ B Nur die grobe Kraft der Hände beim festen Greifen von alltäglichen Gegenständen
- ☐ C Die funktionale Selbstständigkeit inklusive motorischer und kognitiver Anteile
- ☐ D Vorrangig die Sehschärfe und das räumliche Sehvermögen des betroffenen Patienten

**268 Was ist das Ziel von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA)?**

● ●

- ☐ A Die rein medizinische Genesung
- ☐ B Die dauerhafte Wiedereingliederung ins Arbeitsleben
- ☐ C Die häusliche Grundpflege
- ☐ D Die reine Freizeitgestaltung

**269 Wer trägt in der Regel die Reha nach einem Arbeitsunfall?**

● ●

- ☐ A Die gesetzliche Pflegekasse des betroffenen Patienten
- ☐ B Das örtlich zuständige Sozialamt der Gemeinde
- ☐ C Die private Haftpflichtversicherung des Verunfallten
- ☐ D Die gesetzliche Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)

**270 Was gehört zur Stumpfpflege nach einer Amputation?**

● ●

- ☐ A Den Stumpf möglichst nicht berühren
- ☐ B Tägliche Hautinspektion, Reinigung und fachgerechtes Wickeln zur Stumpfformung
- ☐ C Nur einmal wöchentlich kontrollieren
- ☐ D Sofort dauerhaft die Prothese tragen

**271 Welcher Grundsatz gilt im deutschen Sozialrecht (SGB)?**

● ●

- ☐ A Reha vor Pflege
- ☐ B Pflege vor Reha
- ☐ C Reha statt Pflege immer
- ☐ D Pflege schließt Reha aus

**272 In welcher Reihenfolge zieht man einen Menschen mit Halbseitenlähmung aus?**

● ●

- ☐ A Zuerst die gesunde Seite ausziehen
- ☐ B Zuerst die betroffene Seite ausziehen
- ☐ C Immer beide Arme gleichzeitig
- ☐ D Die Reihenfolge ist unwichtig

**273 Was bedeutet Ressourcenorientierung in der rehabilitativen Pflege?**

●

- ☐ A Defizite betonen
- ☐ B Vorhandene Fähigkeiten erkennen und fördern
- ☐ C Alle Tätigkeiten abnehmen
- ☐ D Den Pflegeaufwand reduzieren

**274 Wer gehört typischerweise zum interprofessionellen Reha-Team?**

●

- ☐ A Ausschließlich Pflegekräfte gemeinsam mit dem Reinigungsdienst
- ☐ B Ausschließlich die behandelnden Ärzte und die Klinikverwaltung
- ☐ C Ausschließlich die nahen Angehörigen des Patienten
- ☐ D Pflege, Ärzte, Physio-/Ergotherapie, Logopädie, Sozialdienst

**275 Welchen Nutzen hat ein Rollator?**

●

- ☐ A Er gibt Gang- und Standsicherheit und entlastet beim Gehen
- ☐ B Er ersetzt vollständig das Gehen
- ☐ C Er dient nur dem Transport von Gegenständen
- ☐ D Er ist bei Gangunsicherheit ungeeignet

**276 Wie geht man bei Spastik richtig vor?**

● ● ●

- ☐ A Kräftig und ruckartig dehnen
- ☐ B Das betroffene Glied ruhigstellen und nie bewegen
- ☐ C Ausschließlich kalte Reize einsetzen
- ☐ D Langsame, geführte Bewegungen und korrekte Lagerung statt ruckartiger Dehnung

**277 Was ist ein Hauptziel der geriatrischen Rehabilitation?**

●

- ☐ A Die vollständige Heilung sämtlicher bestehender Erkrankungen
- ☐ B Erhalt von Selbstständigkeit und Vermeidung von Pflegebedürftigkeit
- ☐ C Die dauerhafte Versorgung des Patienten in der Klinik
- ☐ D Die gezielte Reduzierung der sozialen Kontakte

**278 Wer trägt medizinische Reha häufig bei erwerbstätigen Versicherten?**

● ●

- ☐ A Die gesetzliche Rentenversicherung
- ☐ B Die Pflegekasse
- ☐ C Das Jobcenter
- ☐ D Die Berufsgenossenschaft

**279 Was besagt der sozialrechtliche Grundsatz „Reha vor Pflege“?**

● ●

- ☐ A Pflege ist immer günstiger als Rehabilitation
- ☐ B Reha ist nur für junge Menschen vorgesehen
- ☐ C Rehabilitation hat Vorrang, um Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder zu mindern
- ☐ D Pflegebedürftige haben keinen Reha-Anspruch

**280 Was misst der Barthel-Index?**

● ●

- ☐ A Den Blutdruck
- ☐ B Ausschließlich das Sturzrisiko
- ☐ C Die Selbstständigkeit bei Alltagsaktivitäten (ADL)
- ☐ D Die Nahrungsaufnahme in Kalorien

## 15 Anerkennung & Berufszulassung

20 Fragen

### 281 Was gilt für die Berufsbezeichnung „Pflegefachfrau/Pflegefachmann“? ●●

- ☐ A Jede beliebige Person darf sie ohne Voraussetzung führen
- ☐ B Sie ist völlig frei wählbar und an keine Bedingung geknüpft
- ☐ C Sie ist lediglich eine höfliche Anrede ohne rechtliche Bedeutung
- ☐ D Sie ist geschützt und darf nur mit staatlicher Erlaubnis (Urkunde) geführt werden

### 282 Was ist die Schweigepflicht in der Pflege? ●●

- ☐ A Schweigepflicht gilt nur für Ärzte
- ☐ B Alle patientenbezogenen Infos vertraulich
- ☐ C Pflege darf nichts sagen
- ☐ D Angehörige dürfen immer informiert werden

### 283 Was bedeutet Berufserlaubnis auf Zeit? ●●●

- ☐ A Befristete Berufserlaubnis bis zur Anerkennung
- ☐ B Probearbeitsvertrag
- ☐ C Urlaubsregelung
- ☐ D Unbefristete Berufsurkunde

### 284 Was sind Expertenstandards der DNQP? ●●●

- ☐ A Wissenschaftlich begründete Handlungsempfehlungen für die Pflege
- ☐ B Die Prüfungsrichtlinien des Medizinischen Dienstes (MDK)
- ☐ C Verbindliche internationale Standards für die Pflege
- ☐ D Fachliche Vorgaben, die ausschließlich für Ärzte gelten

### 285 Was ist Bezugspflege? ●●

- ☐ A Feste Pflegeperson für einen Patienten
- ☐ B Pflege nur durch Angehörige
- ☐ C Täglicher Teamwechsel
- ☐ D Jede Pflegekraft pflegt alle Patienten

### 286 Wer stellt in der Regel den Pflegegrad fest bzw. begutachtet ihn? ●●

- ☐ A Ausschließlich der behandelnde Hausarzt allein ohne weitere Beteiligung
- ☐ B Der Medizinische Dienst (MD) bzw. bei Privatversicherten Medicproof
- ☐ C Der jeweilige Arbeitgeber der pflegebedürftigen oder erkrankten Person
- ☐ D Die zuständige Pflegeschule im Rahmen der praktischen Ausbildung

### 287 Worin unterscheidet sich die Anerkennung von EU- und Drittstaatsabschlüssen häufig? ●●

- ☐ A Zwischen EU- und Drittstaatsabschlüssen besteht kein Unterschied
- ☐ B EU-Pflegeabschlüsse werden oft automatisch anerkannt, Drittstaatsabschlüsse durchlaufen eine Einzelfallprüfung
- ☐ C Abschlüsse aus Drittstaaten werden grundsätzlich nie anerkannt
- ☐ D Abschlüsse aus EU-Staaten werden grundsätzlich nie anerkannt

**288 Was ist ein Defizitbescheid?**

● ●

- ☐ A Ablehnungsbescheid
- ☐ B Dokument das wesentliche
- ☐ C Sprachzeugnis
- ☐ D Arbeitsvertrag

**289 Was bedeutet die pflegerische Sorgfaltspflicht?**

● ●

- ☐ A Man muss die Pflege in möglichst kurzer Zeit erledigen
- ☐ B Pflege ist nach anerkanntem fachlichen Standard sorgfältig und gewissenhaft auszuführen
- ☐ C Aufgetretene Fehler sollen möglichst verdeckt und vertuscht werden
- ☐ D Die sorgfältige Ausführung ist letztlich freiwillig und optional

**290 Wann wird eine rechtliche Betreuung eingerichtet?**

● ●

- ☐ A Wenn ein Mensch seine Angelegenheiten krankheits- oder behinderungsbedingt nicht mehr selbst regeln kann und keine Vollmacht vorliegt
- ☐ B Grundsätzlich automatisch mit der Vollendung des fünfundsechzigsten Lebensjahres
- ☐ C Regelmäßig bei jeder stationären Aufnahme in ein Krankenhaus oder eine Klinik
- ☐ D Auf ausdrücklichen Wunsch von Nachbarn, Bekannten oder entfernten Verwandten

**291 Was sind die Pflegegrade in Deutschland?**

●

- ☐ A 1-5
- ☐ B 0-4
- ☐ C A-D
- ☐ D 1-3

**292 Was ist das SGB XI?**

● ●

- ☐ A Arbeitsschutzgesetz
- ☐ B Berufsrecht der Pflege
- ☐ C Soziale Pflegeversicherung
- ☐ D Krankenversicherungsgesetz

**293 Was schreibt das Arbeitszeitgesetz unter anderem vor?**

● ●

- ☐ A Beliebige lange Schichten ohne Pause
- ☐ B Gar keine Ruhezeiten
- ☐ C Dass Nachtdienst grundsätzlich verboten ist
- ☐ D Höchstarbeitszeiten, Ruhepausen und Mindestruhezeiten zwischen den Diensten

**294 Was ist vor der Anwendung bestimmter Medizingeräte durch das Personal erforderlich?**

● ●

- ☐ A Es sind überhaupt keine Voraussetzungen dafür erforderlich
- ☐ B Eine Einweisung in das jeweilige Gerät (nach Medizinproduktegesetz)
- ☐ C Ein kurzer Blick in den Herstellerprospekt genügt völlig
- ☐ D Die Zustimmung der Küche der Einrichtung ist einzuholen

**295**
**Welche Behörde ist seit 01.01.2024 für Fachweiterbildungs-Anerkennungen in NRW zuständig?**

● ●

- ☐ A Bundesgesundheitsministerium
- ☐ B Pflegekammer NRW
- ☐ C BIBB
- ☐ D Bezirksregierung Düsseldorf

**296**
**Wozu dient die Datenbank „anabin“?**

● ● ●

- ☐ A Zur Bewertung ausländischer Bildungsabschlüsse und Hochschulen
- ☐ B Der Planung und Verwaltung der Dienste des Personals
- ☐ C Der Bestellung und Nachverfolgung benötigter Medikamente
- ☐ D Der Verwaltung und Abstimmung des Jahresurlaubs

**297**
**Auf wie vielen Modulen beruht das Neue Begutachtungsassessment (NBA) zur Pflegegrad-Einstufung?**

● ● ●

- ☐ A Auf zwei Modulen, die körperliche und geistige Fähigkeiten zusammenfassend abbilden
- ☐ B Auf vier Modulen, die sich eng an den früheren klassischen Pflegestufen orientieren
- ☐ C Auf 6 Modulen (z. B. Mobilität, Selbstversorgung, kognitive Fähigkeiten)
- ☐ D Auf zwölf Modulen mit jeweils einem eigenen medizinischen Fachbereich pro Modul

**298**
**Was ist das Ziel eines Anpassungslehrgangs?**

● ●

- ☐ A Die deutsche Sprache von Grund auf zu lernen
- ☐ B Festgestellte wesentliche Unterschiede zur deutschen Ausbildung praktisch auszugleichen
- ☐ C Ein komplett neues Studium zu absolvieren
- ☐ D Die Approbation als Arzt zu erlangen

**299**
**Welches Sprachniveau ist für den Anpassungslehrgang erforderlich?**

●

- ☐ A B1
- ☐ B A2
- ☐ C B2
- ☐ D C1

**300**
**Was ist die Pflegekammer NRW?**

● ● ●

- ☐ A Ein Ausbildungsinstitut
- ☐ B Eine Gewerkschaft
- ☐ C Berufsständische Körperschaft
- ☐ D Ein Krankenhaus

# Lösungsschlüssel & Erklärungen

Richtige Antwort und kurze Begründung zu jeder Frage.

## Generalistische Ausbildung & Recht

- 1 **C** Der Träger der praktischen Ausbildung (z. B. Krankenhaus, Pflegeeinrichtung, ambulanter Dienst) schließt den Ausbildungsvertrag, zahlt die Vergütung und verantwortet die praktische Ausbildung – organisiert über Kooperationsverträge mit der Pflegeschule und weiteren Einsatzstellen.
- 2 **A** Die generalistische Pflegeausbildung dauert in Vollzeit 3 Jahre, in Teilzeit bis zu 5 Jahre. Sie gliedert sich in theoretischen und praktischen Unterricht an der Pflegeschule und praktische Einsätze bei Trägern der praktischen Ausbildung.
- 3 **A** Vorbehaltene Tätigkeiten (§ 4 PflBG) dürfen nur von ausgebildeten Pflegefachpersonen ausgeübt werden – dazu zählen die Erhebung des Pflegebedarfs, die Organisation und Steuerung des Pflegeprozesses sowie die Analyse und Evaluation der Pflegequalität.
- 4 **A** Die Pflichteinsätze umfassen die stationäre Akutpflege (Krankenhaus), die stationäre Langzeitpflege (z. B. Pflegeheim), die ambulante Pflege sowie je einen Einsatz in der pädiatrischen und der psychiatrischen Versorgung – so wird die generalistische Breite abgedeckt.
- 5 **B** 3. Praxisbegleitung (Ende Jahr 3): komplexe Pflegesituationen, Koordination, Evaluation des gesamten Pflegeprozesses. Gesamter Pflegeprozess inkl. Pflegediagnosen.
- 6 **B** Kinaesthetics: Pflegende lernen natürliche Bewegungsmuster nutzen → weniger Kraftaufwand → Eigenaktivität des Patienten fördern. Weniger Rückenschäden beim Personal.
- 7 **D** Der Pflegeprozess beginnt mit der Informationssammlung (Assessment): Daten über den Menschen, seine Ressourcen und Probleme werden erhoben. Darauf bauen Pflegediagnosen, Zielsetzung, Planung, Durchführung und schließlich die Evaluation auf.
- 8 **C** 1. Praxisbegleitung (Ende Jahr 1): Schwerpunkte CE 01-03. Pflegeprozess anwenden, Körperpflege, Lagerung, Vitalzeichen, Grunddokumentation.
- 9 **D** Evaluation: systematisch prüfen ob Ziele erreicht. Wenn nein → Ursachen analysieren, Plan ändern. Evaluation ist kontinuierlich.
- 10 **B** Die Ausbildung umfasst insgesamt rund 4600 Stunden: etwa 2100 Stunden theoretischen und praktischen Unterricht an der Pflegeschule sowie etwa 2500 Stunden praktische Ausbildung in den Einsatzbereichen.
- 11 **D** Nach etwa zwei Dritteln der Ausbildung findet eine Zwischenprüfung statt, die den Ausbildungsstand feststellt. Ein Nichtbestehen führt nicht automatisch zum Ausbildungsende; in einigen Ländern kann auf diesem Stand ein Pflegefachassistenten-Abschluss aufbauen.
- 12 **B** Vertiefungseinsatz: mind. 500h im 3. Ausbildungsdrittel. Hier findet die praktische Abschlussprüfung statt.
- 13 **B** Zugang bietet in der Regel ein mittlerer Schulabschluss oder ein Hauptschulabschluss zusammen mit einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung bzw. einer landesrechtlich geregelten Pflege(fach)assistentenausbildung.
- 14 **A** Pflegeberufegesetz (PflBG) 2020: Zusammenführung GKP + Altenpflege + Kinderkrankenpflege zur generalistischen Ausbildung. Abschluss: Pflegefachmann/-frau.
- 15 **C** Das Selbstpflegemodell von Dorothea Orem betrachtet den Menschen als grundsätzlich zur Selbstpflege fähig. Pflege wird dann nötig, wenn ein Selbstpflegedefizit besteht – sie gleicht dieses Defizit unterstützend, teilweise oder vollständig kompensierend aus.
- 16 **C** NANDA-I: internationales Klassifikationssystem. Aufbau: Problem (P) + Ätiologie/Ursache (Ä/r/t=related to) + Zeichen/Symptome (Z/m/d/s=manifested by). POP = deutschsprachige Alternative.
- 17 **D** 11 Curriculare Einheiten (CE): strukturieren den Theorieunterricht der GPA. Entwickelt von der Fachkommission nach §53 PflBG. CE 01 = Ausbildungsstart bis CE 11 = Koordination/Steuerung.
- 18 **A** PflBG trat 01.01.2020 in Kraft: vereint GKP, Altenpflege und Kinderkrankenpflege.

- 19 **D** Pflichteinsatz Pädiatrie: 120h in Kinder- und Jugendmedizin. Ebenso Pflicht: 120h Psychiatrie und 500h Vertiefungseinsatz.
- 20 **D** CE 06 'In Akutsituationen sicher handeln': Reanimation 30:2, ABCDE-Schema. 2. Ausbildungsjahr.

## Pflegeprozess & Pflegeplanung

- 21 **A** Pflegeplanung: 1. Pflegeproblem (aktuell/potenziell), 2. Pflegeziel (SMART), 3. Pflegemaßnahmen (wer, was, wann), 4. Evaluation.
- 22 **B** Dekubitus-Kategorien: I = nicht-wegdrückbare Rötung (Haut intakt), II = Blasen/Erosion (Teilverlust Dermis), III = Vollhautverlust bis Subkutis, IV = Muskeln/Knochen/Sehnen betroffen.
- 23 **B** Ressourcen: körperliche (kann Arm heben), kognitive (versteht Anweisungen), soziale (Familienhilfe). Müssen explizit dokumentiert werden!
- 24 **C** Pflegebericht: nicht dokumentiert = nicht getan (rechtlich). Inhalt: Vitalzeichen, Maßnahmen, besondere Ereignisse (Sturz, Schmerzen), Reaktionen, Gespräche. Zeitnah = sofort oder spätestens am selben Tag.
- 25 **A** Pflegemaßnahmen müssen konkret sein: WER (wer führt durch?), WAS (welche Maßnahme?), WANN/WIE OFT, WIE (Technik), MIT WAS (Hilfsmittel). Keine vagen Formulierungen!
- 26 **D** Ein Pflegestandard legt verbindlich und nachvollziehbar fest, wie eine bestimmte Pflegemaßnahme (z. B. Katheterisierung, Verbandwechsel) nach aktuellem fachlichen Wissen durchzuführen ist. Er sichert einheitliche Qualität und dient als Orientierung und rechtliche Absicherung.
- 27 **B** C. difficile = Sporenbildner! Sporen sind alkoholresistent → mechanisches Waschen mit Wasser und Seife + Einmalhandtuch. Zusätzlich: Einzelzimmer, Einmalschürze, Handschuhe, Flächendesinfektion mit sporozid wirksamen Mitteln. Keine Darmtransitkost!
- 28 **B** Dauerhaftes Tragen ohne Indikation: falsches Sicherheitsgefühl (Desinfektion wird vergessen), Handschuhe werden zum Übertragungsweg, Hautschäden. Handschuhe ersetzen die Händedesinfektion NICHT – auch nach Handschuhwechsel desinfizieren!
- 29 **D** Pflegeüberleitung (Entlassungsmanagement): Pflegeprobleme, Ressourcen, Maßnahmen, Hilfsmittelbedarf, Medikamente, soziale Situation weitergeben. Expertenstandard DNQP.
- 30 **A** WHO 5 Momente: 1. Vor Patientenkontakt 2. Vor aseptischer Tätigkeit (wichtigster Moment!) 3. Nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten 4. Nach Patientenkontakt 5. Nach Kontakt mit Patientenumgebung. Moment 2 schützt den Patienten, alle anderen schützen auch die Pflegenden.
- 31 **B** Pflegevisite: regelmäßige Überprüfung ob Pflegeziele erreicht, Plan aktuell, Patient zufrieden. Bezugspflegekraft + Patient + ggf. Angehörige. Unterschied: keine Arztvisite!
- 32 **C** NRS: Patient bewertet Schmerz 0-10. Ab NRS ≥ 4 = Handlungsbedarf. Vor und nach Schmerzmedikation dokumentieren. Alternativen: VAS, BPS/CPOT (nicht-kommunikativ).
- 33 **C** Ärztlich: Herzinsuffizienz. Pflegediagnose: 'Beeinträchtigte Körperpflege r/t Kurzatmigkeit m/d/s Erschöpfung beim Waschen'. Eigenständige pflegerische Kompetenz!
- 34 **C** Potenzielle Pflegeprobleme = Risiken: z.B. 'Gefahr eines Dekubitus wegen Immobilität'. Erfordern prophylaktische Maßnahmen.
- 35 **B** Sterile Handschuhe: Anlegen mit Non-Touch-Technik. Vor Öffnen: Verpackung auf Unversehrtheit und Ablaufdatum prüfen. Indikationen: OP, sterile Katheterisierung, Wundversorgung bei tiefen/kontaminierten Wunden, Legen von ZVK.
- 36 **D** Wäschesortierung: Roter Sack = Infektionswäsche (MRSA, C. diff., Norovirus, stark blutig/kontaminiert) → direkt verschließen, nicht im Zimmer sortieren, Handschuhe + Kittel. Weißer Sack = normale Wäsche. Wäsche NIE ausschütteln → Aerosolbildung → Keimverbreitung!
- 37 **B** MRSA-Isolierung: Einzelzimmer (eigenes Bad), Schutzkittel, Handschuhe, FFP2-Maske bei engem Kontakt. Beim Verlassen: PSA im Zimmer ablegen → Händedesinfektion. Besuch möglich (Kittel + Handschuhe). Patienten aufklären und einbeziehen! Screening: Nasen-Rachen-Abstrich.

- 38 **C** Pflegeproblem vollständig: P = Problem + Ä = Ursache/Ätiologie (r/t = related to) + Z = Zeichen (m/d/s = manifested by).  
Beispiel: Beeinträchtigte Mobilität r/t Schmerzen m/d/s Schonhaltung.
- 39 **B** SMART: Spezifisch (konkrete Handlung: gehen), Messbar (10m), Attraktiv, Realistisch, Terminiert (3. postop. Tag). Vage Ziele sind nicht auswertbar!
- 40 **A** Henderson (1966): 14 Grundbedürfnisse (Atmen, Essen/Trinken, Ausscheiden, Bewegen, Schlafen, Kleiden, Körpertemperatur, Körperpflege, Gefahrenvermeidung, Kommunizieren, Glauben, Beschäftigung, Spielen/Lernen). Pflege: Hilfe zur Selbstständigkeit.

## Prävention & Gesundheitsförderung

- 41 **B** Die Ständige Impfkommision (STIKO) am Robert Koch-Institut erstellt die nationalen Impfeempfehlungen.
- 42 **B** Motivational Interviewing stärkt die intrinsische Motivation zur Verhaltensänderung durch empathische, nicht-konfrontative Gesprächsführung.
- 43 **B** BGM zielt darauf, Arbeitsbedingungen gesundheitsförderlich zu gestalten, Belastungen zu reduzieren und Gesundheit sowie Motivation der Beschäftigten langfristig zu erhalten (z. B. Ergonomie, Rückenschule, Pausenkultur).
- 44 **C** Rückenschonendes Arbeiten: in die Knie gehen und aus den Beinen heben, den Rücken gerade halten, die Last körpernah führen, Drehbewegungen vermeiden und Hilfsmittel bzw. Kinaesthetics nutzen. Das beugt Muskel-Skelett-Erkrankungen vor.
- 45 **D** Beim Fingertest wird die Rötung kurz weggedrückt: Bleibt sie bestehen (nicht wegdrückbar), liegt bereits ein Dekubitus Kategorie 1 vor. Eine wegdrückbare Rötung ist eine reversible Hyperämie.
- 46 **C** Patientenedukation (Information, Schulung, Beratung) stärkt die Gesundheitskompetenz und das Selbstmanagement chronisch Kranker.
- 47 **A** Das RKI ist die zentrale Bundeseinrichtung für Krankheitsüberwachung und Prävention; bei ihm ist auch die STIKO angesiedelt. Die Arzneimittelzulassung übernehmen dagegen BfArM und PEI.
- 48 **A** Das Händedesinfektionsmittel wird in ausreichender Menge über mindestens 30 Sekunden in die trockenen Hände eingerieben; alle Flächen müssen benetzt sein und die Hände die ganze Zeit feucht bleiben.
- 49 **A** Die hygienische Händedesinfektion ist die einfachste und wirksamste Einzelmaßnahme zur Verhütung von Krankenhausinfektionen und zur Eindämmung multiresistenter Erreger.
- 50 **A** Salutogenese fragt nach gesundheitserhaltenden Faktoren. Zentral: Kohärenzgefühl (Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Sinnhaftigkeit).
- 51 **D** Sekundärprävention erkennt Krankheiten früh (Screening/Früherkennung), z.B. Haut- oder Darmkrebscreening, um rechtzeitig behandeln zu können.
- 52 **D** Sorgfältige Mundpflege, Anregung des Speichelflusses (z. B. Kauen) und ausreichende Flüssigkeit beugen Mundsoor (Pilzbefall) und Parotitis (Ohrspeicheldrüsenentzündung) vor, besonders bei Nahrungskarenz.
- 53 **B** Zur Basis-/physikalischen Thromboseprophylaxe gehören Frühmobilisation, Bewegungsübungen, Kompression (MTPS) und ausreichende Flüssigkeit; medikamentös ergänzt niedermolekulares Heparin. Bettruhe fördert Thrombosen.
- 54 **A** Gegen Tröpfchen- bzw. aerogen übertragene Erreger schützt vor allem ein korrekt sitzender Mund-Nasen-Schutz bzw. eine FFP2/FFP3-Maske, ergänzt um Händehygiene und ggf. eine Schutzbrille.
- 55 **B** Modifizierbare Risikofaktoren wie Rauchen, Bewegungsmangel, Fehlernährung, Übergewicht und Bluthochdruck lassen sich durch Prävention beeinflussen. Alter, Geschlecht und Erbanlagen sind nicht veränderbar.
- 56 **C** Quartärprävention zielt darauf, Patienten vor unnötiger oder schädlicher Über-Diagnostik und Über-Therapie zu schützen (Vermeidung von Overtreatment).
- 57 **C** Die WHO definiert 5 Indikationen: vor Patientenkontakt, vor aseptischer Tätigkeit, nach Kontakt mit potenziell infektiösem Material, nach Patientenkontakt und nach Kontakt mit der Patientenumgebung.

- 58 **D** Wegen des Kontakts mit Blut und Körperflüssigkeiten ist die Hepatitis-B-Impfung für Pflegepersonal Standard (Arbeitsschutz, ArbMedVV).
- 59 **B** Aufrechte Position (ca. 90°), ruhiges Tempo, kleine Bissen, angepasste Konsistenz (z. B. angedickte Flüssigkeit bei Dysphagie) und Konzentration aufs Schlucken senken das Aspirationsrisiko.
- 60 **C** Empowerment befähigt Menschen, mehr Kontrolle über Entscheidungen und Handlungen zu gewinnen, die ihre Gesundheit beeinflussen.

## Mobilität & Bewegung

- 61 **A** Der Rollator hat Räder (oft mit Bremse und Sitz) für kontinuierliches Gehen; ein Gehbock wird angehoben und versetzt und gibt sehr viel Standstabilität.
- 62 **D** Bewegung in vollem Bewegungsausmaß und physiologische Gelenkstellung erhalten die Beweglichkeit. Immobilität fördert Kontrakturen.
- 63 **C** Sturzprophylaxe im Umfeld: ausreichende Beleuchtung, rutschfestes Schuhwerk, Haltegriffe und die Beseitigung von Stolperfallen wie Teppichen und Kabeln.
- 64 **D** Ein Bewegungsförderungsplan wird individuell erstellt (Ressourcen, Risiken, Ziele), regelmäßig evaluiert und dokumentiert – gemäß Expertenstandard Mobilität.
- 65 **D** Bei Orthostase-Gefahr stufenweise mobilisieren (Oberkörper hoch, an die Bettkante setzen, Kreislauf anpassen lassen), um Schwindel und Sturz durch Blutdruckabfall zu vermeiden.
- 66 **C** Der DNQP-Expertenstandard fokussiert systematische Risikoeinschätzung (z.B. Braden) und konsequente Druckentlastung/ Bewegungsförderung zur Vermeidung.
- 67 **C** Aktivierende Pflege bezieht vorhandene Fähigkeiten ein und fördert Selbstständigkeit statt vollständiger Übernahme.
- 68 **A** Rückenschonend: Last körpfernah, aus den Beinen heben (Knie beugen), Rücken gerade halten, Drehbewegungen der Wirbelsäule vermeiden und Hilfsmittel nutzen.
- 69 **B** Sturzrisikofaktoren sind u. a. Polypharmazie (v. a. Sedativa und Antihypertensiva), Seh- und Gleichgewichtsstörungen, Orthostase sowie Umgebungsgefahren.
- 70 **C** Das Bobath-Konzept ist ein neurophysiologischer Ansatz zur Förderung von Menschen mit zentralen Bewegungsstörungen (z. B. Hemiplegie nach Schlaganfall).
- 71 **D** Ein Lifter dient dem sicheren Transfer schwer mobiler Patienten und schützt vor Sturz und Rückenschäden. Anwendung nach Einweisung und mit passendem Gurt.
- 72 **B** Frühmobilisation, Bewegungsübungen, ausreichende Hydratation und ggf. MTPS/medikamentöse Prophylaxe senken das Thromboserisiko.
- 73 **B** Bei der 30°-Schräglage wird das Gewicht auf die weniger gefährdete Gesäßmuskulatur verlagert und die Knochenvorsprünge (Kreuzbein, Trochanter major) werden entlastet.
- 74 **D** Mikrolagerung verlagert durch kleine Bewegungen regelmäßig die Druckpunkte, ohne den Patienten stark umzulagern – schonend und dekubitusprophylaktisch wirksam.
- 75 **C** Die Virchow-Trias nennt die drei Hauptfaktoren der Thromboseentstehung: Gefäßwand- bzw. Endothelschaden, Stase (z. B. durch Immobilität) und Hyperkoagulabilität.
- 76 **B** Mobilisation erfolgt stufenweise und ressourcenorientiert: Aufsetzen, an die Bettkante, sicherer Stand, dann erste Schritte – jeweils mit Kreislauf- und Sicherheitskontrolle.
- 77 **B** Ein Rutsch- bzw. Transferbrett überbrückt den Spalt und erleichtert sitzende Transfers, z. B. vom Bett in den Rollstuhl – schonend für Patient und Pflegekraft.
- 78 **D** Vor dem Transfer: Bremsen von Rollstuhl und Bett feststellen, Fußstützen wegklappen, rutschfeste Schuhe, klare Ansage und ggf. Hilfsmittel nutzen – so werden Stürze vermieden.

- 79 **B** In Rückenlage lasten die höchsten Drücke auf Kreuzbein, Fersen, Hinterkopf und Schulterblättern – die typischen Prädilektionsstellen.
- 80 **B** Bei fortgeschrittener pAVK kann Kompression die ohnehin reduzierte arterielle Durchblutung weiter verschlechtern – daher Vorsicht bzw. Kontraindikation und ärztliche Abklärung.

## Notfall & Akutsituationen

- 81 **A** Erwachsene: 30 Kompressionen zu 2 Beatmungen.
- 82 **C** Die stabile Seitenlage ist für bewusstlose Personen mit normaler Atmung: Sie hält die Atemwege frei und beugt einer Aspiration vor. Bei fehlender normaler Atmung: Reanimation.
- 83 **C** E = Exposure/Environment: den Patienten situationsgerecht entkleiden und vollständig untersuchen, dabei Auskühlung vermeiden (Wärmeerhalt).
- 84 **C** Typisch: anhaltender Druck/Schmerz hinter dem Brustbein mit möglicher Ausstrahlung in Arm, Kiefer oder Rücken, Luftnot, Kaltschweißigkeit, Übelkeit. Bei Frauen und Diabetikern oft atypisch.
- 85 **C** Bei Asystolie/PEA wird nicht defibrilliert; im Vordergrund stehen ununterbrochene, hochwertige Thoraxkompressionen und frühzeitig Adrenalin (1 mg i.v.).
- 86 **C** A = Airway: zuerst die Atemwege sichern bzw. freimachen (ggf. mit HWS-Schutz).
- 87 **D** 112 ist der europaweite Notruf für Rettungsdienst und Feuerwehr. 110 ist die Polizei, 116117 der ärztliche Bereitschaftsdienst.
- 88 **A** MTS hat 5 Stufen: Rot (sofort), Orange (10 min), Gelb (30 min), Grün (90 min), Blau (120 min).
- 89 **A** 100–120/min, Drucktiefe 5–6 cm, vollständige Entlastung zwischen den Kompressionen.
- 90 **C** Kleinflächige Verbrennungen mit handwarmem/lauwarmem Wasser kühlen (kein Eis – Erfrierungsgefahr), keine Hausmittel, Blasen nicht öffnen, locker keimarm bedecken. Bei großflächigen Verbrennungen kein ausgedehntes Kühlen (Auskühlung).
- 91 **B** C = Circulation: Puls, Blutdruck, Rekapillarierungszeit, Blutung stillen, Zugang und Volumen.
- 92 **A** Drucktiefe 5–6 cm in der Brustmitte (untere Sternumhälfte).
- 93 **D** Grün = normal/Standard, maximal 90 Minuten.
- 94 **C** Effektive Kompressionen: harte Unterlage, Tiefe 5–6 cm, Frequenz 100–120/min, vollständige Entlastung (Recoil) nach jeder Kompression und minimale Unterbrechungen.
- 95 **B** Beim Kind (durch Fachpersonal): 5 initiale Beatmungen, dann Verhältnis 15:2, Drucktiefe etwa ein Drittel des Brustkorbdurchmessers. Laien dürfen 30:2 anwenden.
- 96 **C** Der hypovolämische Schock entsteht durch Volumenmangel (Blutung, Flüssigkeitsverlust). Weitere Formen: kardiogen, septisch, anaphylaktisch, neurogen.
- 97 **A** Schockzeichen: blasse, kühle, feuchte Haut, Tachykardie mit schwachem Puls, Blutdruckabfall, verlängerte Rekapillarierungszeit sowie Unruhe oder Bewusstseinsstörung.
- 98 **D** Bei ineffektivem Husten: bis zu 5 Rückenschläge zwischen die Schulterblätter, dann bis zu 5 Oberbauchkompressionen (Heimlich), im Wechsel – bis der Fremdkörper heraus ist oder Bewusstlosigkeit eintritt (dann Reanimation).
- 99 **B** Orange = sehr dringend, maximal 10 Minuten.
- 100 **A** B = Breathing: Atmung beurteilen – Atemfrequenz, Atemtiefe/-muster, SpO<sub>2</sub>, Auskultation, Thoraxbewegungen; ggf. Sauerstoffgabe.

## Innere Medizin

- 101 **A** Hypertonie:  $\geq 140/90$  mmHg (mehrfach gemessen in Ruhe). Optimaler RR  $< 120/80$ . Hypertensive Krise:  $> 180/120$  mmHg mit Symptomen  $\rightarrow$  Notfall!
- 102 **A** Bikarbonat liegt normal bei etwa 22–26 mmol/l. Es ist der metabolische Parameter und sinkt z. B. bei metabolischer Azidose.
- 103 **C** Normal sind etwa 95–99 %. Unter 90 % besteht eine relevante Hypoxämie. Bei COPD können individuell niedrigere Zielwerte gelten (ärztliche Vorgabe).
- 104 **D** Die arterielle BGA wird durch arterielle Punktion (häufig A. radialis, vorher Allen-Test) oder über einen arteriellen Katheter gewonnen. Die kapilläre BGA (Ohrläppchen) ist eine Alternative mit Einschränkungen.
- 105 **C** Dysphagie = Schluckstörung. Stille Aspiration (kein Husten!) besonders gefährlich  $\rightarrow$  Aspirationspneumonie. Logopädie, angepasste Kostform (IDDSI), OK-Hochlagerung beim Essen, kein Strohhalm!
- 106 **D** FAST: F=Face (hängt eine Gesichtshälfte?), A=Arms (beide Arme hebbar?), S=Speech (Sprache undeutlich/fehlend?), T=Time (Uhrzeit notieren, sofort 112!).
- 107 **C** Asthma verläuft typischerweise anfallsartig mit weitgehend reversibler Obstruktion (oft allergisch), während die COPD eine chronische, nur teilreversible Obstruktion ist.
- 108 **B** Azidose = pH unter 7,35 (das Blut ist zu sauer), Alkalose = pH über 7,45. Ursachen können respiratorisch ( $p\text{CO}_2$ ) oder metabolisch ( $\text{HCO}_3^-$ ) sein.
- 109 **A** pH-Werte unter etwa 7,0 oder über 7,8 sind akut lebensbedrohlich (Enzym- und Organfunktion). Der Normbereich ist mit 7,35–7,45 eng.
- 110 **D** Bei respiratorischer Azidose staut sich  $\text{CO}_2$  (Hypoventilation):  $p\text{CO}_2$  steigt, der pH sinkt. Zur Kompensation steigt später das  $\text{HCO}_3^-$  (renale Kompensation).
- 111 **C** NYHA III = Symptome (Dyspnoe, Erschöpfung) bereits bei leichter körperlicher Belastung wie Treppensteigen. NYHA I = keine Symptome, NYHA IV = Ruhedyspnoe.
- 112 **C** Die Kussmaul-Atmung ist eine tiefe, regelmäßig vertiefte Atmung, mit der bei metabolischer Azidose (z. B. diabetischer Ketoazidose) vermehrt  $\text{CO}_2$  abgeatmet wird.
- 113 **D** Bobath: betroffene Seite aktivieren statt kompensieren. Patient von betroffener Seite ansprechen, Lagerung auf beiden Seiten, alle Aktivitäten beidseitig. Fördert Neuroplastizität.
- 114 **D** Das Lungenödem zeigt sich durch schwere Dyspnoe, feuchte/brodelnde Rasselgeräusche und ggf. schaumigen Auswurf. Sofortmaßnahmen: Oberkörper hoch, Beine tief, Sauerstoff, Arzt.
- 115 **C** COPD mit chronischer Hyperkapnie: hypoxischer Atemantrieb. Zu viel  $\text{O}_2$  ( $\text{SpO}_2 > 92\%$ )  $\rightarrow$  Atemdepression  $\rightarrow$   $\text{CO}_2$ -Narkose. Ziel- $\text{SpO}_2$ : 88–92%!
- 116 **C** Bei Hyperventilation wird zu viel  $\text{CO}_2$  abgeatmet:  $p\text{CO}_2$  sinkt, der pH steigt (respiratorische Alkalose). Typisch bei Angst/Panik mit Kribbeln und Pfötchenstellung.
- 117 **C** Der  $p\text{CO}_2$  spiegelt die Atmung wider (respiratorischer Parameter).  $\text{HCO}_3^-$  und Base Excess sind die metabolischen Parameter.
- 118 **B** Der normale arterielle pH liegt bei 7,35–7,45. Werte unter 7,35 bedeuten Azidose, über 7,45 Alkalose. Der Bereich ist eng reguliert.
- 119 **D** Der  $p\text{CO}_2$  liegt normal bei etwa 35–45 mmHg. Er ist der respiratorische Parameter und steigt z. B. bei Hypoventilation.
- 120 **A** Die Lungenembolie zeigt sich oft mit plötzlicher Atemnot, atemabhängigem Brustschmerz, Tachykardie, ggf. Husten/Hämoptyse; Ursache meist eine tiefe Beinvenenthrombose. Notfall – 112.

## Chirurgie

- 121 **C** Frühmobilisation reduziert Thrombose, Pneumonie, Dekubitus und paralytischen Ileus, fördert Kreislauf und Darmtätigkeit und beschleunigt die Genesung – schmerzadaptiert und sicher durchgeführt.

- 122 **C** Klassische Entzündungszeichen: Rötung, Schwellung, Überwärmung, Schmerz und Funktionseinschränkung – bei Wundinfektion oft mit eitrigem Sekret und ggf. Fieber. Arzt informieren.
- 123 **A** Beim Harnverhalt kann die gefüllte Blase nicht spontan entleert werden (z. B. nach Narkose/Regionalanästhesie). Zeichen: Unterbauchschmerz, tastbare Blase, Harndrang ohne Miktions. Ggf. Einmalkatheterisierung.
- 124 **A** Übliche Nüchternheitsgrenzen: klare Flüssigkeiten bis 2 Stunden, leichte/feste Nahrung bis 6 Stunden vor der Narkose – zur Vermeidung einer Aspiration bei der Narkoseeinleitung.
- 125 **D** Der paralytische Ileus ist eine Darmlähmung mit Stillstand der Peristaltik, z. B. nach Bauch-OP. Zeichen: geblähter Bauch, fehlende Darmgeräusche, Übelkeit/Erbrechen, kein Stuhl-/Windabgang. Frühmobilisation beugt vor.
- 126 **D** Falls nötig, wird zeitnah vor der OP mit einem Clipper gekürzt statt mit Klinge rasiert – Mikroverletzungen durch Klingenrasur erhöhen das Wundinfektionsrisiko.
- 127 **B** Drainagen werden nach ärztlicher Anordnung gezogen, meist wenn die Sekretförderung deutlich nachgelassen hat. Vorher Menge/Verlauf dokumentieren; das Ziehen erfolgt aseptisch.
- 128 **B** NRS: 0=kein Schmerz, 10=maximal. Ab NRS  $\geq 4$  = Handlungsbedarf. Analgetikum nach Anordnung. Wirkungskontrolle nach 30-60 Min. dokumentieren. Nicht erst bei NRS 8 reagieren!
- 129 **A** Die Redon-Drainage ist eine geschlossene Wunddrainage mit Sog (Unterdruck), die Wundsekret/Blut ableitet und die Wundränder anlegt. Sog und Fördermenge werden überwacht und dokumentiert.
- 130 **B** KEINE Wärme bei Appendizitisverdacht! Wärme  $\rightarrow$  Vasodilatation  $\rightarrow$  Entzündungsförderung  $\rightarrow$  erhöhtes Perforationsrisiko.
- 131 **D** Stomapflege: Vitalität/Farbe (rosig-feucht) beurteilen, Peristomahaut schützen, dicht sitzende Versorgung wählen, Ausscheidung beobachten und die Betroffenen schrittweise zur selbstständigen Versorgung anleiten (Psyche beachten).
- 132 **B** PONV = postoperative Übelkeit und Erbrechen, häufig nach Narkosen (Risiko u. a. Frauen, Nichtraucher, Reisekrankheit). Prophylaxe/Therapie mit Antiemetika, Aspiration vermeiden.
- 133 **C** McBurney-Punkt: rechter Unterbauch, Mitte zwischen Nabel und Spina iliaca anterior superior. Typisch für Appendizitis. Blumberg-Zeichen = Loslassschmerz = Peritonitis-Zeichen!
- 134 **B** Bei Drainagen werden Fördermenge und Sekretbeschaffenheit dokumentiert, Sog und Durchgängigkeit kontrolliert, die Eintrittsstelle beobachtet und Zeichen einer Nachblutung (plötzlich viel frisches Blut) erkannt.
- 135 **D** TEP-Thromboseprophylaxe: TVT-Rate ohne Prophylaxe bis 40%! NMH 4-6 Wochen, Kompressionsstrümpfe, Frühmobilisation. NMH wird subkutan gespritzt, Blutungszeichen beachten.
- 136 **B** Die Bilanzierung (Ein-/Ausfuhr inkl. Urin, Drainagen, Erbrochenes) erkennt frühzeitig Flüssigkeitsdefizite, Nachblutungen oder Nierenprobleme und steuert die postoperative Flüssigkeitstherapie.
- 137 **B** Vor einem Eingriff muss der einwilligungsfähige Patient rechtzeitig ärztlich aufgeklärt werden und einwilligen. Ohne wirksame Einwilligung ist der Eingriff (außer im Notfall) rechtswidrig.
- 138 **A** Beim Verbandwechsel werden Wundgröße/-tiefe, Wundgrund, Wundränder und -umgebung, Sekretmenge, -farbe und -geruch sowie Entzündungszeichen beurteilt und dokumentiert (ggf. Fotodokumentation).
- 139 **C** Die Markierung der Eingriffsstelle und das Team-Time-out (OP-Checkliste) dienen der Patientensicherheit und verhindern Seiten- und Eingriffsverwechslungen.
- 140 **A** Komplikationen nach Appendektomie: Wundinfektion (3-5%), intraabdomineller Abszess (bei Perforation), Darmparalyse/Ileus (Blähbauch, kein Darmgeräusch), Nachblutung. Frühmobilisation reduziert Ileus.

## Pädiatrie

- 141 **A** Muttermilch ist optimal an den Bedarf des Säuglings angepasst, leicht verdaulich und enthält Antikörper (v. a. IgA), die einen „Nestschutz“ bieten und Infektionen vorbeugen. Stillen fördert zudem die Mutter-Kind-Bindung.

- 142** **D** Scharlach wird durch A-Streptokokken (Bakterien) verursacht und zeigt sich mit Fieber, Halsschmerzen, Himbeerzunge und feinfleckigem Ausschlag. Er wird mit Antibiotika (z. B. Penicillin) behandelt, um Komplikationen und Folgeerkrankungen vorzubeugen.
- 143** **B** Motorische Meilensteine: 3 Mo. = Kopfkontrolle. 5-6 Mo. = Drehen. 7-8 Mo. = freies Sitzen. 8-10 Mo. = Krabbeln. 10-14 Mo. = Stehen, erste Schritte. Variationsbreite beachten! Alarm: kein Sitzen mit 9 Mo., kein Laufen mit 18 Mo.
- 144** **C** GPA-Pflichteinsatz Pädiatrie: 120h in Kinder- und Jugendmedizin. Ziel: altersspezifische Besonderheiten, Entwicklungsstufen, familienorientierte Pflege.
- 145** **C** Im Kindes- und Jugendalter überwiegt der Diabetes Typ 1, eine Autoimmunerkrankung mit absolutem Insulinmangel. Er erfordert eine lebenslange Insulintherapie. Warnzeichen sind starker Durst, häufiges Wasserlassen, Gewichtsverlust und Müdigkeit.
- 146** **B** Neonataler Ikterus: physiologisch (Tag 2-7), durch Abbau fetaler RBC (höhere Hämoglobin-Konzentration). Pathologisch: innerhalb 24h, >2 Wochen, Reifgeborene >17mg/dl → Phototherapie (Blaulicht 420-490nm). Stillen fördern erhöht Ausscheidung.
- 147** **A** Kinderdosierung: immer mg/kg Körpergewicht. Pharmakokinetik unterschiedlich (Reifung Leber/Niere). Wichtig: Kein Aspirin <12 Jahre (Reye-Syndrom-Risiko!). Kindgerechte Darreichungsform (Saft, Zäpfchen). Elternaufklärung über korrekte Dosierung.
- 148** **C** Fieberkrampf: häufigste Krampfform im Kindesalter (2-4%). Meist generalisiert, <5 Min., selbstlimitierend. Maßnahmen: Kind schützen (Stürze), Seitenlagerung, Zeit messen, Notarzt bei >5 Min. Danach: Fieber senken, Ursache suchen, Eltern aufklären.
- 149** **A** Exsikkose (Dehydratation): häufig bei Kinder durch Erbrechen/Durchfall. Zeichen: trockene Schleimhäute, eingesunkene Fontanelle (Säugling), stehende Hautfalte (>2s), Oligurie, dunkler Urin, Tachykardie, Lethargie. Behandlung: orale/i.v. Rehydratation.
- 150** **A** Rooming-in: Eltern bleiben Tag und Nacht beim Kind. Vorteile: Stärkung Eltern-Kind-Bindung, Stillen fördern, Kind fühlt sich sicher, Eltern lernen Pflege, reduziert Hospitalisierungsangst. Gesetzlich verankert (§ 2 Kinderschutz).
- 151** **A** Normwerte AF: Neugeborene 40-60/min, Säuglinge 30-50/min, Kleinkinder 25-35/min, Schulkinder 20-25/min, Erwachsene 12-18/min. Neugeborene atmen periodisch – kurze Atempausen bis 10s normal!
- 152** **B** Normwerte HF: Neugeborene 120-160/min, Säuglinge 100-140/min, Kleinkinder 90-130/min, Schulkinder 70-110/min, Erwachsene 60-100/min. Wichtig: altersgerechte Normwerte kennen!
- 153** **A** Altersgerechte Schmerzeinschätzung: Neugeborene/Säuglinge → KUSS (Kinder-Unbehagen/Schmerzskala, beobachtungsbasiert). Vorschulkinder → FACES-Skala (Smiley-Skala). Schulkinder ab 8J. → NRS 0-10. Selbstauskunft immer bevorzugen!
- 154** **D** Ein Frühgeborenes ist ein Kind, das vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche (SSW) geboren wird. Je unreifer, desto höher das Risiko für Probleme bei Atmung, Temperaturregulation, Ernährung und Infektabwehr.
- 155** **D** Kinder werden altersgerecht, ehrlich und auf Augenhöhe informiert – in einfacher Sprache, ohne Ängste zu bagatellisieren oder falsche Versprechen zu machen. Spielerische Elemente, Vorbereitung auf Maßnahmen und die Nähe einer Bezugsperson geben Sicherheit.
- 156** **A** Pseudokrupp (Laryngotracheitis): meist viral (Parainfluenza). Symptome: bellender Husten, Heiserkeit, inspiratorischer Stridor, besonders nachts. Behandlung: kühle feuchte Luft (Fenster auf), Kortison (Dexamethason/Rectodelt), Kind beruhigen, bei schwerem Anfall Klinik.
- 157** **D** Kindesmisshandlung: körperlich (Hämatome, Knochenbrüche), emotional (Vernachlässigung, psychische Gewalt), sexuell. Schutzauftrag §8a SGB VIII: Hinweise dokumentieren, Kinderarzt einbeziehen, Kinderschutzteam, ggf. Jugendamt. Schweigepflicht kann zurücktreten!
- 158** **B** Kleinkinder sind sehr neugierig und unfallgefährdet. Zur Prävention gehören Treppen- und Herdschutzgitter, Steckdosensicherungen, das sichere Verwahren von Medikamenten, Reinigungsmitteln und Kleinteilen (Verschluckungsgefahr) sowie Aufsicht am und im Wasser.

- 159 **D** Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) ist eine häufige Ursache von Bronchiolitis und obstruktiver Bronchitis bei Säuglingen, v. a. in den Wintermonaten. Symptome sind Husten, Atemnot, Giemen und Trinkschwäche; Frühgeborene sind besonders gefährdet.
- 160 **C** Windpocken werden durch das Varizella-Zoster-Virus verursacht und sind hochansteckend. Typisch ist ein juckender, schubweiser Ausschlag mit Bläschen in verschiedenen Stadien. Dasselbe Virus kann später als Gürtelrose (Herpes zoster) reaktivieren.

## Cynäkologie & Geburtshilfe

- 161 **D** Das CTG zeichnet Wehen und kindliche Herztöne auf. Herzfrequenzabfälle können auf eine fetale Hypoxie hinweisen.
- 162 **C** Wegen relativ großer Körperoberfläche und unreifer Wärmeregulation drohen Auskühlung/Hypothermie – Abtrocknen, Haut-zu-Haut, Mütze beugen vor.
- 163 **A** Das Kind hat vermehrt Insulin gebildet; nach Wegfall des mütterlichen Zuckerangebots droht eine neonatale Hypoglykämie.
- 164 **D** Reichen Ernährung und Bewegung nicht, wird mit Insulin behandelt; orale Antidiabetika werden in der Schwangerschaft i. d. R. nicht eingesetzt.
- 165 **C** Ursächlich beseitigt wird HELLP nur durch die Entbindung; bis dahin RR-Senkung, Magnesium (Krampfprophylaxe), Kortison (Lungenreife).
- 166 **C** APGAR bewertet Atmung, Puls, Grundtonus, Aussehen und Reflexe (je 0–2 Punkte) bei 1, 5 und 10 Minuten. 7–10 gilt als unauffällig.
- 167 **D** Korrektes Anlegen: Kind erfasst Mamille samt großem Teil des Warzenhofs, Lippen nach außen, Kinn an der Brust – beugt wunden Mamillen vor.
- 168 **B** HELLP = Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets – eine schwere Verlaufsform der Präeklampsie.
- 169 **A** Kortison (Betamethason) beschleunigt die kindliche Lungenreife/Surfactant-Bildung und senkt das Risiko eines Atemnotsyndroms.
- 170 **C** Prolaktin bildet die Milch, Oxytocin löst den Let-down-Reflex aus. Häufiges Anlegen fördert über den Saugreiz beide Hormone.
- 171 **D** Bei Mastitis meist weiterstillen/entleeren (Milchstau lösen!), kühlen, schonen; bei Fieber ggf. Antibiotikum. Abstillen ist selten nötig.
- 172 **D** Nach OP und im Wochenbett ist das Thromboserisiko erhöht: LMWH, Kompression, frühe Mobilisation – plus Wochenbett-Kontrollen (Fundus, Lochien).
- 173 **A** Die U1 erfolgt unmittelbar nach der Geburt (inkl. APGAR). Die U2 folgt am 3.–10. Lebenstag mit dem Neugeborenen-Screening.
- 174 **C** Geburtsbeginn: regelmäßige, zunehmende Wehen, Blasensprung (Fruchtwasserabgang) und Zeichnen (Abgang des blutig-schleimigen Schleimpfropfs).
- 175 **D** Der rechtsseitige Oberbauchschmerz entsteht durch Spannung der Leberkapsel – mit Übelkeit, Kopfschmerz und Hypertonie ein Warnzeichen.
- 176 **C** Der oGTT wird in der 24.–28. SSW durchgeführt, da der GDM meist symptomarm verläuft und sonst unentdeckt bliebe.
- 177 **D** Stillen ist nach Sectio möglich, durch Wundschmerz und verzögerten Milcheinschuss oft erschwert – aktive Stillberatung und schmerzarme Positionen helfen.
- 178 **C** Not-Sectio bei akuter Gefahr für Mutter oder Kind: path. CTG, Nabelschnurvorfal, vorzeitige Plazentalösung, Geburtsstillstand.
- 179 **D** Eröffnungsphase (Muttermund bis 10 cm), Austreibungsphase (vollständige Eröffnung bis Geburt des Kindes, Presswehen), Nachgeburtsphase (Geburt der Plazenta).
- 180 **D** Frühgeburt = Geburt vor abgeschlossener 37. SSW. Je unreifer, desto höher das Risiko für Atemprobleme und Infektionen.

## Psychiatrie

- 181** **B** Demenz (ICD-10 F00-F03): organischer, fortschreitender kognitiver Abbau. Depression: affektive Störung, behandelbar. Pseudodemenz: Depression die wie Demenz aussieht → Therapieversuch! Unterscheidung wichtig für Behandlungsplanung.
- 182** **C** Borderline (ICD-10 F60.3): instabile Emotionen, Impulsivität, instabile Beziehungen (Idealisierung/Entwertung), Identitätsstörung, Selbstverletzung, Suizidalität, chronische Leere. DBT (Dialektisch-Behaviorale Therapie) als Behandlung.
- 183** **A** Panikattacke: plötzliche intensive Angst, Herzrasen, Atemnot, Schwindel, Entfremdungsgefühl. Pflegerische Reaktion: ruhig bleiben, bei Patient bleiben, ruhige Stimme, Atemübungen (Ein 4-7-8), Umgebung sichern, keine Dramatisierung.
- 184** **B** Schizophrenie (ICD-10 F20): Positivsymptome = Halluzinationen (häufig akustisch), Wahn, Denkstörungen, Ich-Störungen. Negativsymptome = Affektverflachung, Antriebslosigkeit, sozialer Rückzug. Kein 'gespaltenes Gehirn'!
- 185** **D** De-Eskalation: 1. Sicherheit (Abstand, Fluchtwege), 2. Ruhige Haltung/Stimme, 3. Empathie zeigen, 4. Bedürfnisse erfragen, 5. Wahlmöglichkeiten anbieten, 6. Unterstützung holen. Fixierung immer letztes Mittel!
- 186** **C** Suizidalitätsstufen: passive Suizidgedanken ('wäre besser wenn ich nicht da wäre') → konkrete Pläne (Mittel, Zeit, Ort) → Absicht → Versuch. JEDE Erwähnung ernst nehmen! Direkte Frage erlaubt: 'Denken Sie an Suizid?'
- 187** **B** Einwilligungsfähigkeit meint, dass die Person Wesen, Bedeutung und Folgen einer Behandlung erfassen und danach frei entscheiden kann. Sie wird situationsbezogen beurteilt und ist unabhängig von der Geschäftsfähigkeit. Fehlt sie, greifen Betreuungsrecht bzw. Unterbringungsregeln.
- 188** **C** GPA-Pflichteinsatz Psychiatrie: 120h in psychiatrischer Versorgung. Ziel: Grundlagen psychischer Erkrankungen kennen, therapeutische Kommunikation anwenden.
- 189** **B** Therapeutische Kommunikation: aktives Zuhören, Empathie zeigen, offene Fragen stellen, spiegeln, nicht bewerten, Gefühle ansprechen, Schweigen aushalten. Basis jeder psychiatrischen Pflege.
- 190** **A** Milieutherapie: gesamte Stationsumgebung als therapeutisches Instrument. Elemente: klare Tagesstruktur, soziale Regeln, Gruppenangebote (Ergotherapie, Sport, Kochen), therapeutische Gemeinschaft, Patienten übernehmen Verantwortung.
- 191** **B** Krisenintervention ist zeitlich begrenzte, unmittelbare Hilfe zur Stabilisierung. Ein bekanntes Schema ist BELLA: Beziehung aufbauen, Erfassen der Situation, Linderung der Symptome, Leute einbeziehen, Ansatz zur Problembewältigung. Ziel ist Entlastung und Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit.
- 192** **D** Bei der Schizophrenie beschreibt die Positivsymptomatik ein „Zuviel“ (Wahn, Halluzinationen, Ich-Störungen), die Negativsymptomatik ein „Zuwenig“ (Antriebsmangel, sozialer Rückzug, Affektverflachung, Sprachverarmung). Negativsymptome sind oft schwerer behandelbar.
- 193** **A** Das Delirium tremens ist eine lebensbedrohliche Komplikation des Alkoholentzugs mit Bewusstseins- und Orientierungsstörung, Tremor, Halluzinationen, Unruhe sowie vegetativen Zeichen (Schwitzen, Tachykardie, Blutdruckanstieg). Es erfordert engmaschige Überwachung und Behandlung.
- 194** **C** PsychKG NRW: Zwangseinweisung und -behandlung nur bei unmittelbarer Eigen- oder Fremdgefährdung + richterlicher Genehmigung. Verhältnismäßigkeit! Dokumentation Pflicht. Pflegepersonal hat keine eigenständige Zwangsbefugnis.
- 195** **A** Benzodiazepine wirken angstlösend und beruhigend, bergen aber bei längerer Einnahme ein hohes Abhängigkeitsrisiko sowie Sturz-, Sedierungs- und Toleranzrisiken. Sie werden daher möglichst kurzzeitig und kontrolliert eingesetzt.
- 196** **D** Psychoedukation: strukturierte Vermittlung von Wissen über die Erkrankung (Was ist Schizophrenie?), Medikamente (Wirkung/NW), Frühwarnsymptome, Rückfallprävention. Fördert Compliance und Selbstmanagement.
- 197** **B** Ein strukturierter Tagesablauf (feste Zeiten für Mahlzeiten, Aktivitäten, Ruhe) gibt Orientierung und Sicherheit, wirkt Antriebslosigkeit und Grübeln entgegen und fördert Selbstständigkeit. Er ist zentraler Bestandteil der Milieutherapie, besonders bei Depression und Psychosen.
- 198** **B** Ein Delir entsteht akut (Stunden bis Tage), schwankt im Verlauf und ist bei Behandlung der Ursache (z. B. Infektion, Exsikkose, Medikamente) meist reversibel. Eine Demenz entwickelt sich schleichend und chronisch-fortschreitend. Ein Delir kann eine Demenz überlagern.

- 199 **C** Extrapyramidale Nebenwirkungen sind medikamentös bedingte Bewegungsstörungen: z. B. Früh dyskinesien (Muskelkrämpfe), Parkinsonoid (Rigor, Tremor), Akathisie (Bewegungsunruhe) und Spätdyskinesien. Sie treten v. a. unter typischen Antipsychotika auf und müssen erkannt werden.
- 200 **A** Bei Intoxikation steht die vitale Sicherung im Vordergrund: engmaschige Kontrolle von Bewusstsein, Atmung, Kreislauf; Aspirationsschutz (stabile Seitenlage bei Bewusstseinstörung), Schutz vor Auskühlung und Selbstgefährdung. Psychische Begleitung folgt, wenn der Zustand stabil ist.

## Psychologie & Kommunikation

- 201 **D** Maslow: erst wenn Grundbedürfnisse erfüllt, strebt Mensch nach oben. Pflegerrelevant: Physiologische Bedürfnisse (Essen, Trinken, Schmerz) zuerst sichern, dann psychosoziale.
- 202 **B** Die Basale Stimulation fördert Wahrnehmung, Kommunikation und Bewegung durch gezielte, angepasste Sinnesreize (z. B. Berührung, Bewegung). Sie richtet sich v. a. an Menschen mit stark eingeschränkter Eigenaktivität.
- 203 **C** MI (Miller & Rollnick): Patient soll eigene Motivation entwickeln. Prinzipien: Empathie, Diskrepanz entwickeln, Widerstand vermeiden, Selbstwirksamkeit stärken. Höhere Nachhaltigkeit als direktive Beratung.
- 204 **C** Schulz von Thun: Sachinhalt (Info), Selbstoffenbarung (über Sender), Beziehungsebene (zum Empfänger), Appell (was soll Empfänger tun?). Missverständnisse: Sender und Empfänger sprechen/hören auf verschiedenen Ebenen.
- 205 **C** Nach Lazarus entsteht Stress aus der subjektiven Bewertung einer Situation (Bedrohung/Herausforderung) und der Einschätzung der eigenen Bewältigungsmöglichkeiten (Coping). Nicht die Situation allein, sondern ihre Bewertung ist entscheidend.
- 206 **A** GFK: 1. Beobachtung (ohne Bewertung), 2. Gefühl, 3. Bedürfnis, 4. Bitte (keine Forderung). Unterschied: Beobachtung ≠ Bewertung. Reduziert Konflikte im Team und mit Patienten.
- 207 **A** Burnout-Trias: 1. Emotionale Erschöpfung, 2. Depersonalisation (Zynismus), 3. Reduzierte Leistungsfähigkeit. Messung: Maslach Burnout Inventory (MBI).
- 208 **D** Ich-Botschaften beschreiben die eigene Wahrnehmung und das eigene Gefühl, ohne den anderen anzuklagen. Sie wirken weniger angreifend als Du-Botschaften (Vorwürfe) und fördern konstruktive Gespräche.
- 209 **C** Carl Rogers nennt drei Grundhaltungen: Empathie (einführendes Verstehen), Kongruenz (Echtheit) und bedingungslose Wertschätzung (Akzeptanz) – sie schaffen ein hilfreiches Gesprächsklima.
- 210 **A** Supervision: professionelle Begleitung zur Reflexion beruflicher Situationen. Einzel- oder Gruppensupervision. Ziele: Stressbewältigung, Burnout-Prävention, professionelle Weiterentwicklung, Qualitätssicherung. In der Psychiatriepflege oft Pflicht.
- 211 **A** TTM (Prochaska): Interventionen müssen zum Stadium passen. Bei Absichtslosigkeit: Bewusstsein wecken. Bei Vorbereitung: Handlungsplan. Nicht immer sofort Handlung erwarten!
- 212 **C** Biografiearbeit nutzt die Lebensgeschichte, um Gewohnheiten, Vorlieben und Bedürfnisse zu verstehen und die Pflege individuell und sinnstiftend zu gestalten – besonders wertvoll bei Menschen mit Demenz.
- 213 **A** Hilfreich: dem Menschen zugewandt und deutlich (nicht übertrieben) sprechen, Blickkontakt für das Lippenlesen ermöglichen, Störgeräusche reduzieren, ggf. Schrift, einfache Sprache oder Gebärden nutzen.
- 214 **B** Nach Watzlawick hat jedes Verhalten Mitteilungscharakter: Auch Schweigen, Mimik oder Abwenden senden Botschaften. Man kann sich also nicht 'nicht' verhalten und damit nicht 'nicht' kommunizieren.
- 215 **A** Aktives Zuhören: Blickkontakt, zugewandte Haltung, Nicken, Paraphrasieren ('Sie meinen also...'), Verbalisieren von Gefühlen, offene Fragen. Keine vorschnellen Ratschläge!
- 216 **B** Empathie ist das Einfühlen in Gefühle und Sichtweise des anderen, ohne sich darin zu verlieren. Sie ist Grundlage einer vertrauensvollen Pflegebeziehung – abzugrenzen von handlungslähmendem Mitleid.
- 217 **B** Zur nonverbalen Kommunikation zählen Mimik, Gestik, Körperhaltung, Blickkontakt, Berührung und der Tonfall (paraverbal). Sie transportiert vor allem Beziehungs- und Gefühlsbotschaften.

- 218 **C** Frühzeichen von Überlastung: anhaltende Erschöpfung, Reizbarkeit oder Zynismus, Schlafstörungen, sozialer Rückzug und nachlassende Leistungsfähigkeit. Frühzeitige Selbstfürsorge und Unterstützung beugen einem Burnout vor.
- 219 **D** Bei sehbehinderten Menschen: sich mit Namen ansprechen/vorstellen, Handlungen ankündigen und beschreiben, Orientierung geben und Gegenstände an ihrem Platz belassen bzw. Änderungen mitteilen.
- 220 **B** PMR nach Jacobson: Muskelgruppen 5-10s anspannen → loslassen → Unterschied wahrnehmen. Evidenzbasiert bei Stress, Angst, Schlafstörungen. Von distal nach proximal (Hände → Arme → Schultern → ...).

## Altenpflege & Geriatrie

- 221 **A** Kurzzeitpflege (vorübergehende vollstationäre Pflege, z. B. nach einem Klinikaufenthalt) und Verhinderungspflege (Ersatzpflege bei Ausfall der Pflegeperson) entlasten pflegende Angehörige zeitweise und überbrücken Engpässe. Beide sind Leistungen der Pflegeversicherung (SGB XI).
- 222 **A** Betreuungsrecht (§§1814ff BGB seit 2023): wenn Volljähriger aufgrund Krankheit/Behinderung Angelegenheiten nicht selbst regeln kann → Betreuungsgericht bestellt Betreuer. Vorrang: Vorsorgevollmacht! Betreuer handelt im Wohl der betreuten Person.
- 223 **B** Mangelernährung (Malnutrition): häufig im Alter und bei Demenz. Screening: MNA-SF (Mini Nutritional Assessment Short Form) bei Aufnahme. Risikofaktoren: Kaustörungen, Schluckstörungen (Dysphagie), Demenz, Depression, Medikamente. Maßnahmen: Lieblingsspeisen, angereicherte Kost, Trinknahrung, Ernährungsberatung.
- 224 **D** Biografiearbeit: bei Demenz oft einziger Zugang zum Menschen. Lieblingsspeisen, Musikgeschmack, Berufsbiografie, Rituale kennen → personenzentrierte Pflege. Biografiebogen bei Aufnahme ausfüllen, Angehörige einbeziehen.
- 225 **A** Im Alter wird die Haut dünner, trockener und empfindlicher (weniger Talg, geringere Elastizität). Empfehlenswert sind schonende Reinigung, nicht zu heißes Wasser, milde Waschsubstanzen und rückfettende Pflege, um Hautrisse, Juckreiz und Infektionen zu vermeiden.
- 226 **A** NBA: bewertet 6 Module: 1.Mobilität, 2.Kognition/Kommunikation, 3.Verhaltensweisen, 4.Selbstversorgung, 5.Krankheitsbewältigung, 6.Alltagsgestaltung. Geistige/psychische Beeinträchtigungen gleichwertig wie körperliche!
- 227 **B** Demenz: erworbener, fortschreitender Abbau kognitiver Funktionen. Häufigste Form: Alzheimer (60-70%). Weitere: vaskuläre Demenz (Durchblutungsstörungen), Lewy-Körper-Demenz, frontotemporale Demenz. Nicht heilbar, aber behandelbar!
- 228 **A** Bei einer Altersdepression klagen Betroffene häufig selbst über Gedächtnis- und Antriebsprobleme und wirken traurig oder verzweifelt, während Menschen mit beginnender Demenz Defizite oft bagatellisieren. Die Abgrenzung ist wichtig, da eine Depression gut behandelbar ist (Pseudodemenz).
- 229 **B** Multimorbidität bezeichnet das gleichzeitige Vorliegen mehrerer chronischer Erkrankungen bei einem Menschen – im Alter sehr häufig. Sie erhöht die Komplexität von Behandlung und Pflege und begünstigt u. a. Polypharmazie und Wechselwirkungen.
- 230 **A** Sterbezeichen: Rasselatmung (Sekret), Cheyne-Stokes-Atmung (periodisch), Totenflecken (Livores), kühle/blaue Extremitäten, Bewusstlosigkeit, fehlende Reflexe. Pflegerische Maßnahmen: Mundpflege (wichtigste Maßnahme!), Lagerung, Schmerzkontrolle, Familie informieren und einbeziehen, ruhige Atmosphäre.
- 231 **A** WTG NRW (Wohn- und Teilhabegesetz): regelt stationäre Pflegeeinrichtungen, Tages-/Kurzzeitpflege, Wohngemeinschaften. Heimaufsicht prüft: Personalschlüssel, Qualitätsstandards, Bewohnerrechte, Hygiene, Sicherheit. Bewohner haben Recht auf: Selbstbestimmung, Privatsphäre, Besuch.
- 232 **C** Harninkontinenz: Belastung (Husten/Lachen), Dranginkontinenz (plötzlicher Harndrang), Überlaufinkontinenz (volle Blase), Reflexinkontinenz (neurogen). Würdevoller Umgang! Kontinenzförderung (Blasentraining, Beckenbodenübungen) vor Inkontinenzversorgung. Expertenstandard Kontinenzförderung DNQP.
- 233 **C** Expertenstandard Sturzprophylaxe (DNQP): Risikoeinschätzung bei Aufnahme (z.B. STRATIFY). Maßnahmen: rutschfeste Schuhe, Gehhilfen, Rufanlage in Reichweite, Medikamentenreview (Sedativa!), Umgebung sturzfrei gestalten, Toilettenpläne, Bewegungsförderung. Keine FEM als ersten Schritt!

- 234** **C** Patientenverfügung (§1827 BGB): schriftlich, unterschrieben, datiert. Legt fest welche medizinischen Maßnahmen gewünscht/abgelehnt werden (z.B. keine künstliche Ernährung, kein Reanimationsversuch). Bindend wenn konkret und auf aktuelle Situation anwendbar!
- 235** **A** Kinästhetik in der Altenpflege: besonders wichtig bei immobilen, schwer pflegebedürftigen Menschen. Pflegende führen Bewegungen nicht durch sondern begleiten sie. Weniger Rückenschäden beim Personal, mehr Würde für Bewohner, Eigenaktivität auch bei Schwerstpflegebedürftigen fördern.
- 236** **B** Validation: demenzkranker Mensch sagt 'Ich muss nach Hause zu meinen Kindern' → NICHT: 'Ihre Kinder sind erwachsen' → SONDERN: 'Sie vermissen Ihre Kinder sehr.' Gefühle ernst nehmen, nicht in Realität zwingen.
- 237** **D** SGB XI Leistungen: Pflegegeld (für häusliche Pflege durch Angehörige), Sachleistung (ambulanter Pflegedienst), Kombinationsleistung, vollstationäre Pflege, Kurzzeitpflege (bis 8 Wochen/Jahr), Verhinderungspflege (bis 6 Wochen), Entlastungsbetrag 125€/Monat.
- 238** **D** Bei Demenz helfen leicht essbares Fingerfood, vertraute und beliebte Speisen, eine ruhige Essatmosphäre, klare Präsentation, ausreichend Zeit und Anleitung. So bleiben Selbstständigkeit und eine ausreichende Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme möglichst lange erhalten.
- 239** **A** Ambulante Pflege: Patient bleibt zu Hause, ambulanter Dienst kommt. SGB XI: Sachleistung bis PG5 2.200€/Monat. Stationäre Pflege: Umzug ins Pflegeheim, Eigenanteil gestiegen. Zwischenformen: Tagespflege (tagsüber), Kurzzeitpflege (bis 8 Wo.), Nachtpflege, betreutes Wohnen.
- 240** **B** Dysphagie: Schluckstörung häufig nach Schlaganfall, bei Demenz, Parkinson, ALS. Pflegemaßnahmen: 90° Sitzposition, IDDSI-Kostform (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative: püriert, weich-stückig), kein Strohhalm, kein Kopf zurückneigen, Logopädie. Aspirationsgefahr!

## Palliativpflege

- 241** **B** Die Palliativstation ist in ein Krankenhaus integriert (Krisenintervention, Symptomkontrolle), das Hospiz ist eine eigenständige Einrichtung für die letzte Lebensphase.
- 242** **D** Hoffnungen und Wünsche Sterbender – auch scheinbar unrealistische – werden ernst genommen und wertschätzend begleitet. Hoffnung kann sich wandeln (z. B. von Heilung hin zu einem friedlichen Abschied) und gibt Halt.
- 243** **C** Palliative Sedierung senkt kontrolliert und in der niedrigst nötigen Dosis das Bewusstsein, um sonst unerträgliche, therapierefraktäre Symptome (z. B. Atemnot, Unruhe) zu lindern. Sie zielt nicht auf den Tod ab und ist von aktiver Sterbehilfe klar abzugrenzen.
- 244** **A** Mit einer Vorsorgevollmacht bevollmächtigt man eine Vertrauensperson, im Fall der eigenen Entscheidungsunfähigkeit Angelegenheiten (z. B. Gesundheit, Aufenthalt, Finanzen) zu regeln – so wird oft eine gerichtliche Betreuung vermieden.
- 245** **D** In einer Betreuungsverfügung äußert man im Voraus, wen das Betreuungsgericht – falls eine rechtliche Betreuung nötig wird – als Betreuerin oder Betreuer bestellen (oder gerade nicht bestellen) soll.
- 246** **A** In der Sterbephase steht das Wohlbefinden im Vordergrund. Nahrung und Flüssigkeit werden nicht erzwungen; nachlassender Appetit und Durst sind Teil des Sterbeprozesses. Wichtiger als eine Zwangsernährung sind gute Mundpflege und Zuwendung.
- 247** **C** Ein bewusster, würdevoller Abschied am Verstorbenen hilft Angehörigen, den Verlust zu begreifen, und unterstützt eine gesunde Trauerverarbeitung. Pflegende schaffen dafür einen ruhigen, ungestörten Rahmen.
- 248** **D** Atemnot wird durch Oberkörperhochlagerung, Frischluft/Ventilator, Beruhigung und ggf. niedrig dosierte Opiode gelindert.
- 249** **A** Trauer ist ein individueller Prozess. Begleitung bedeutet Zuhören, Dasein und das Zulassen von Gefühlen ohne Bewertung.
- 250** **D** Unsichere Todeszeichen wie Atem- und Pulsstillstand, Blässe, Areflexie oder weite Pupillen können auch bei Bewusstlosigkeit oder Scheintod auftreten. Erst sichere Zeichen (Totenflecke, Totenstarre, Fäulnis) beweisen den Tod.
- 251** **A** Oft ist nicht das „Machen“, sondern das „Dasein“ entscheidend: Präsenz, Zuhören, das Aushalten von Nähe und Stille sowie das Signal „Ich lasse dich nicht allein“ geben Sterbenden Sicherheit und Würde.

- 252 **D** Gute Kommunikation am Lebensende ist wahrhaftig und zugleich einfühlsam: Man belügt den Betroffenen nicht, drängt ihm aber auch keine Informationen auf, sondern orientiert sich an seinem Tempo und seinen Fragen.
- 253 **D** Die Patientenverfügung legt im Voraus fest, welche medizinischen Maßnahmen gewünscht/abgelehnt werden, falls die Person sich nicht mehr äußern kann (§1827 BGB).
- 254 **D** Eine Oberkörperhochlagerung und atemerleichternde Positionen (z. B. Kutschersitz, Armabstützung) entlasten die Atemmuskulatur und lindern Atemnot. Ergänzend helfen frische Luft/Ventilator, Ruhe und ärztlich angeordnete Medikamente (z. B. Opioide).
- 255 **A** Das Durstgefühl Sterbender entsteht meist durch eine trockene Mundschleimhaut, nicht durch einen Flüssigkeitsmangel im Körper. Häufige, sorgfältige Mundpflege und das Befeuchten der Lippen lindern es besser als Infusionen.
- 256 **C** Neuropathische Schmerzen sprechen oft nur begrenzt auf klassische Analgetika an. Als Ko-Analgetika werden u. a. bestimmte Antidepressiva (z. B. Amitriptylin, Duloxetin) und Antikonvulsiva (z. B. Gabapentin, Pregabalin) eingesetzt.
- 257 **B** Übelkeit und Erbrechen werden ursachenorientiert mit Antiemetika (z. B. Metoclopramid, Haloperidol, Dimenhydrinat) behandelt; ergänzend helfen kleine Portionen, frische Luft, Mundpflege und eine ruhige Umgebung.
- 258 **A** Das Sekrettrasseln belastet meist die Angehörigen mehr als den Sterbenden. Maßnahmen: Lagerung, Aufklärung, zurückhaltendes Absaugen, ggf. Anticholinergika.
- 259 **C** Opioide verursachen fast immer Obstipation. Eine Laxanzien-Prophylaxe gehört daher zur Standardbegleitung der Opioidtherapie.
- 260 **C** Spirituelle Begleitung nimmt Sinn-, Glaubens- und Wertefragen ernst, unabhängig von einer bestimmten Religion. Sie kann Gespräche, Rituale oder die Einbindung von Seelsorge umfassen und ist Teil des ganzheitlichen Palliativansatzes.

## Rehabilitation

- 261 **C** Bei einer Schluckstörung (Dysphagie) ist die Logopädie für Diagnostik und Schlucktraining zuständig; die Pflege setzt Empfehlungen (Kostkonsistenz, Positionierung) im Alltag um.
- 262 **D** Das Einbeziehen und Anleiten von Angehörigen sichert die Übertragung von Reha-Erfolgen in den Alltag, stärkt die Selbstständigkeit des Betroffenen und beugt zugleich einer Überforderung der Angehörigen vor.
- 263 **D** Die AHB schließt sich direkt an eine Akutbehandlung (z.B. OP, Schlaganfall) an, um den Behandlungserfolg zu sichern.
- 264 **A** Aktivierend-therapeutische Pflege integriert therapeutische Konzepte (z.B. Bobath, Kinästhetik) in den pflegerischen Alltag und fördert Reha-Ziele rund um die Uhr.
- 265 **A** Das SGB IX zielt auf Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung.
- 266 **C** Aktivierende (rehabilitative) Pflege folgt dem Grundsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“: Der Mensch wird angeleitet und ermutigt, vorhandene Fähigkeiten selbst einzusetzen; unterstützt wird nur dort, wo es nötig ist.
- 267 **C** Der FIM misst die funktionale Selbstständigkeit und berücksichtigt neben motorischen auch kognitive Bereiche (z. B. Kommunikation, soziale Kognition, Problemlösung).
- 268 **B** Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA, berufliche Reha) zielen auf die dauerhafte Wiedereingliederung ins Erwerbsleben – z. B. Umschulung, Qualifizierung oder behinderungsgerechte Arbeitsplatzgestaltung.
- 269 **D** Für die Rehabilitation nach einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit ist die gesetzliche Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) zuständig und leistet „mit allen geeigneten Mitteln“.
- 270 **B** Nach einer Amputation gehören tägliche Hautinspektion, sorgfältige Reinigung und fachgerechtes Wickeln (Kompression) zur Ödemreduktion und Formung des Stumpfes zur Vorbereitung der Prothesenversorgung.
- 271 **A** Der Grundsatz 'Reha vor Pflege' (SGB) bedeutet: Rehabilitationsmaßnahmen sollen Pflegebedürftigkeit vermeiden oder mindern, bevor Pflege greift.
- 272 **A** Beim Ausziehen wird die gesunde Seite zuerst befreit, sodass der weniger bewegliche betroffene Arm anschließend leichter aus dem Kleidungsstück geführt werden kann („gesund zuerst aus, betroffen zuerst an“).

- 273 **B** Ressourcenorientierung knüpft an vorhandene Fähigkeiten an und stärkt Eigenaktivität und Selbstwirksamkeit.
- 274 **D** Interprofessionelle Rehabilitation verbindet u.a. Pflege, Medizin, Physio-, Ergotherapie, Logopädie und Sozialdienst.
- 275 **A** Ein Rollator ist ein Gehhilfsmittel, das Stand- und Gangsicherheit erhöht, das Gehen entlastet und mit Sitzfläche Pausen ermöglicht – er fördert Mobilität und Selbstständigkeit.
- 276 **D** Bei Spastik werden ruckartige Reize und schnelle Dehnungen vermieden, da sie den Muskeltonus steigern. Hilfreich sind langsame geführte Bewegungen, physiologische Lagerung und Physiotherapie (z. B. nach Bobath).
- 277 **B** Geriatrische Reha will Alltagskompetenz und Selbstständigkeit erhalten bzw. wiederherstellen - Grundsatz 'Reha vor Pflege'.
- 278 **A** Bei Erwerbstätigen trägt medizinische Rehabilitation häufig die gesetzliche Rentenversicherung, um die Erwerbsfähigkeit zu erhalten oder wiederherzustellen (Grundsatz „Reha vor Rente“).
- 279 **C** Nach dem Grundsatz „Reha vor Pflege“ soll durch rechtzeitige Rehabilitation Pflegebedürftigkeit vermieden, überwunden oder gemindert werden – Reha hat also Vorrang vor reinen Pflegeleistungen.
- 280 **C** Der Barthel-Index erfasst den Grad der Selbstständigkeit bei Aktivitäten des täglichen Lebens (z. B. Essen, Waschen, Ankleiden, Mobilität) und dient als Verlaufsmaß in der Rehabilitation.

## Anerkennung & Berufszulassung

- 281 **D** Die Berufsbezeichnung ist gesetzlich geschützt und darf nur führen, wer die staatliche Erlaubnis (Berufsurkunde) besitzt – nach bestandener deutscher Ausbildung oder erfolgreicher Anerkennung. Das unbefugte Führen ist nicht zulässig.
- 282 **B** Schweigepflicht §203 StGB: alle Heilberufsangehörigen. Verletzung = Straftat. Ausnahme: Kindeswohlgefährdung.
- 283 **A** Berufserlaubnis auf Zeit (§64 PflBG): ermöglicht Berufsausübung während laufendem Anerkennungsverfahren. Befristet, widerrufbar.
- 284 **A** DNQP-Expertenstandards: Dekubitusprophylaxe, Sturzprophylaxe, Schmerzmanagement, Ernährungsmanagement, Kontinenzförderung. Maßstab guter Pflege.
- 285 **A** Bezugspflege (Primary Nursing): eine PK kontinuierlich für bestimmte Patienten zuständig. Vorteile: Beziehungskontinuität, bessere Patientenkenntnis.
- 286 **B** Für die Feststellung des Pflegegrades begutachtet der Medizinische Dienst (MD) – bei Privatversicherten Medicproof – die Pflegebedürftigkeit im Auftrag der Pflegekasse. Grundlage ist das Neue Begutachtungsassessment (NBA).
- 287 **B** Pflegeabschlüsse aus EU-/EWR-Staaten werden aufgrund EU-rechtlicher Regelungen häufig automatisch anerkannt. Abschlüsse aus Drittstaaten durchlaufen dagegen meist eine individuelle Gleichwertigkeitsprüfung mit ggf. Anpassungslehrgang oder Kenntnisprüfung.
- 288 **B** Defizitbescheid: dokumentiert konkret Abweichungen der ausländischen Ausbildung von der deutschen. Grundlage für Anpassungslehrgang oder Kenntnisprüfung.
- 289 **B** Die Sorgfaltspflicht verpflichtet Pflegende, ihre Tätigkeit nach dem aktuellen anerkannten Stand des Wissens und gewissenhaft auszuführen. Ein Verstoß (z. B. grobe Nachlässigkeit mit Schaden) kann zivil-, arbeits- und strafrechtliche Folgen haben.
- 290 **A** Eine rechtliche Betreuung wird vom Betreuungsgericht eingerichtet, wenn ein volljähriger Mensch seine Angelegenheiten krankheits- oder behinderungsbedingt nicht mehr selbst besorgen kann und keine wirksame Vorsorgevollmacht besteht. Sie ist auf die nötigen Aufgabenbereiche begrenzt.
- 291 **A** Pflegegrade 1-5 nach SGB XI seit 2017. PG1 = geringe Beeinträchtigung, PG5 = schwerste Beeinträchtigung. Einstufung durch MDK.
- 292 **C** SGB XI = Sozialgesetzbuch XI = Soziale Pflegeversicherung seit 1995. Regelt Leistungen bei Pflegebedürftigkeit.
- 293 **D**

Das Arbeitszeitgesetz regelt u. a. die werktägliche Höchstarbeitszeit, vorgeschriebene Ruhepausen und die Mindestruhezeit (in der Regel 11 Stunden) zwischen zwei Diensten. Es schützt die Gesundheit der Beschäftigten – gerade im Schichtdienst der Pflege.

- 294 **B** Nach dem Medizinproduktegesetz (z. B. MPBetreibV) dürfen aktive Medizinprodukte nur von eingewiesenem Personal betrieben werden. Die Einweisung in Funktion und sichere Handhabung (z. B. Infusionspumpe, Beatmungsgerät) wird dokumentiert.
- 295 **B** Seit 01.01.2024 Pflegekammer NRW für Fachweiterbildungs-Anerkennungen. Grundausbildungen: Bezirksregierungen NRW.
- 296 **A** anabin ist eine Informationsdatenbank zur Bewertung und Einordnung ausländischer Bildungsabschlüsse und Hochschulen. Sie unterstützt Behörden und Antragstellende bei der Einschätzung, wie ein ausländischer Abschluss eingeordnet wird.
- 297 **C** Das NBA erfasst die Selbstständigkeit in sechs Modulen: Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen/psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen sowie Gestaltung des Alltagslebens. Daraus ergibt sich der Pflegegrad.
- 298 **B** Der Anpassungslehrgang gleicht die im Defizitbescheid festgestellten wesentlichen Unterschiede aus. Er findet überwiegend in der Praxis (mit theoretischen Anteilen) statt und schließt mit einem Abschlussgespräch bzw. einer Bewertung ab.
- 299 **C** B2-Deutschkenntnisse Pflicht – nötig für Fachunterricht und Patientenkommunikation.
- 300 **C** Pflegekammer NRW: Körperschaft des öffentlichen Rechts. Mitgliedschaft für exam. Pflegefachkräfte Pflicht. Aufgaben: Berufsregister, Weiterbildungsanerkennung (seit 2024), Berufsordnung.



### **Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.**

Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf [plan-nrw.de](https://plan-nrw.de)